

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

LES SYNDROMES TOPOGRAPHIQUES

DR.MENNOUR.SOROR
Maitre Assistante en neurologie
Faculté de médecine CONSTANTINE
Année universitaire 2025/2026

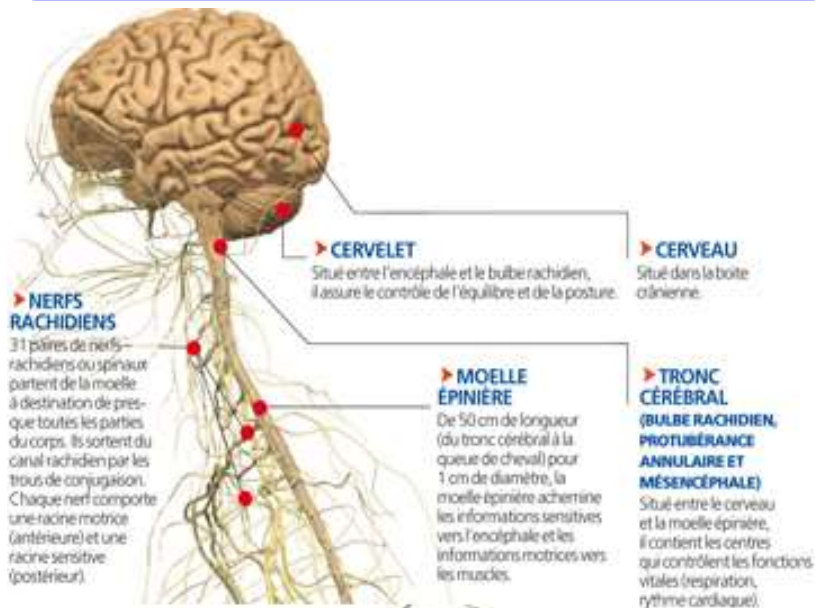
- Le diagnostic anatomique consiste à fixer le siège d'une lésion donnée du système nerveux à partir des différents signes et symptômes cliniques du patient.

2

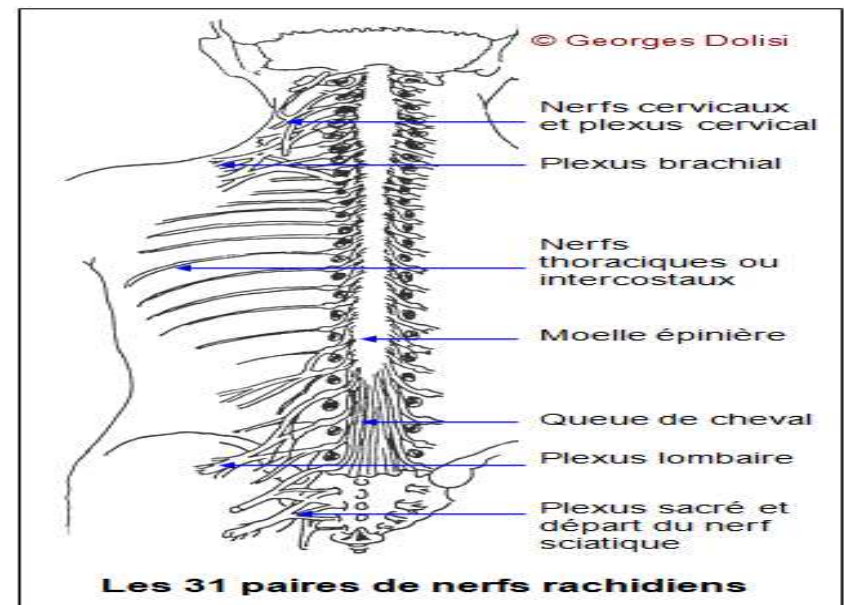
RAPPEL ANATOMIQUE

SYSTÈME NERVEUX

SYSTÈME NERVEUX CENTRAL



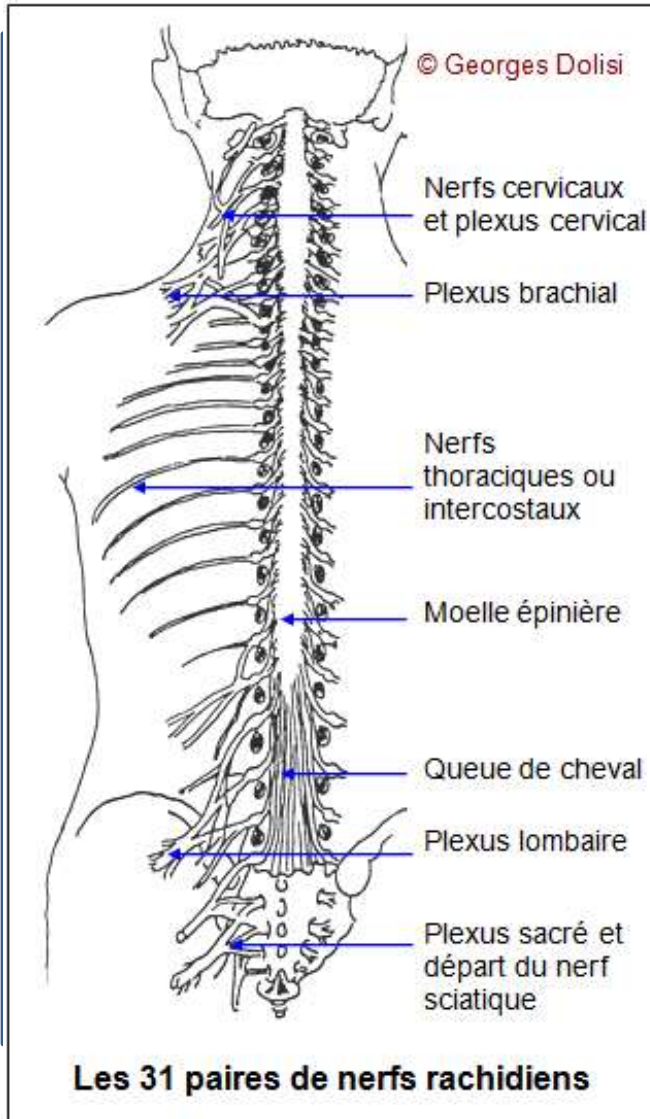
SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE



**SYNDROMES
TOPOGRAPHIQUES DU
SYSTEME NERVEUX
PERIPHERIQUE**

1

RAPPEL ANATOMIQUE (1)

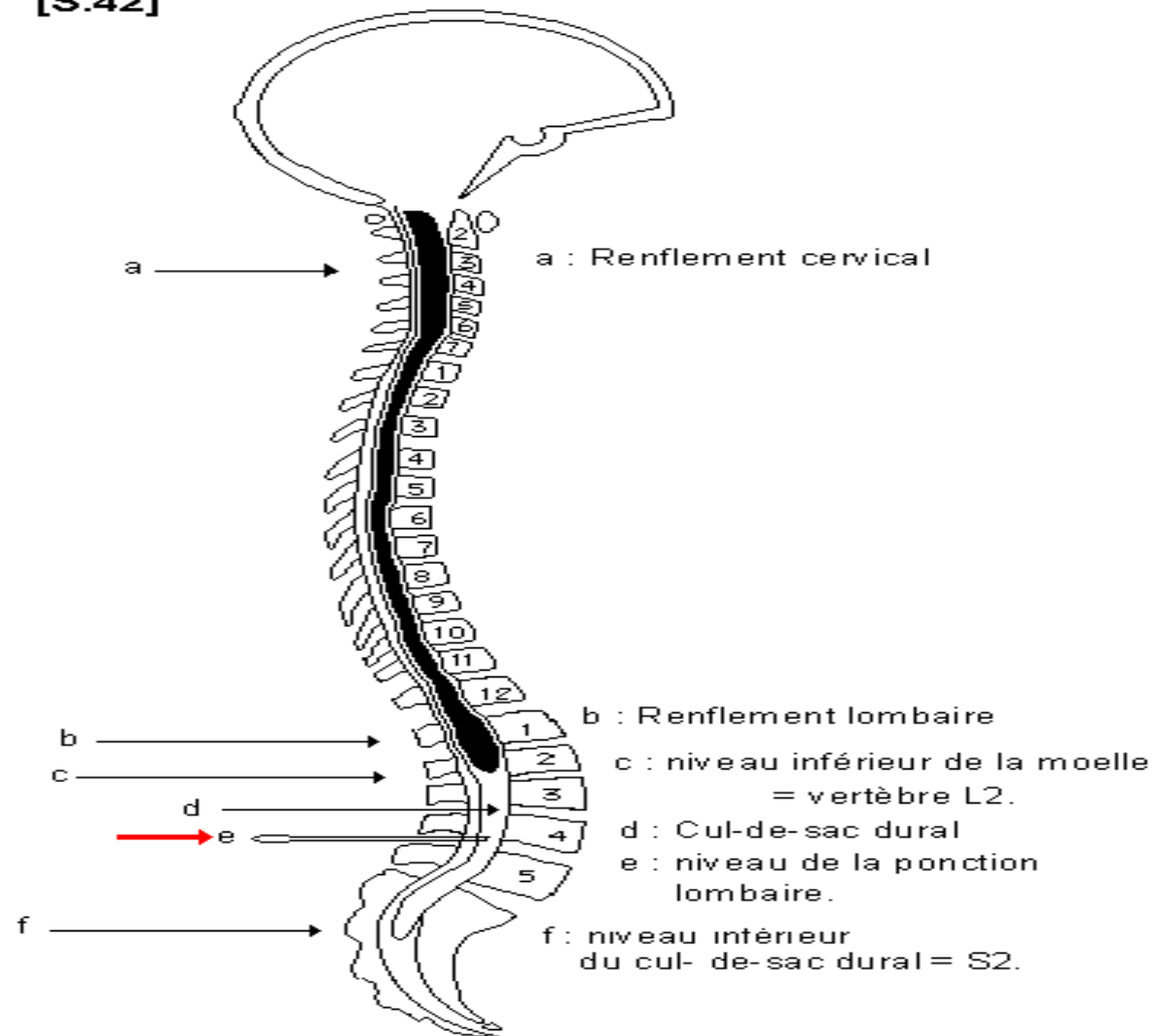


Ils sont au nombre de 31 nerfs rachidiens:

- 8 nerfs cervicaux,
- 12 nerfs thoraciques,
- 5 nerfs lombaires,
- 5 nerfs sacrés,
- 1 nerf coccygien,

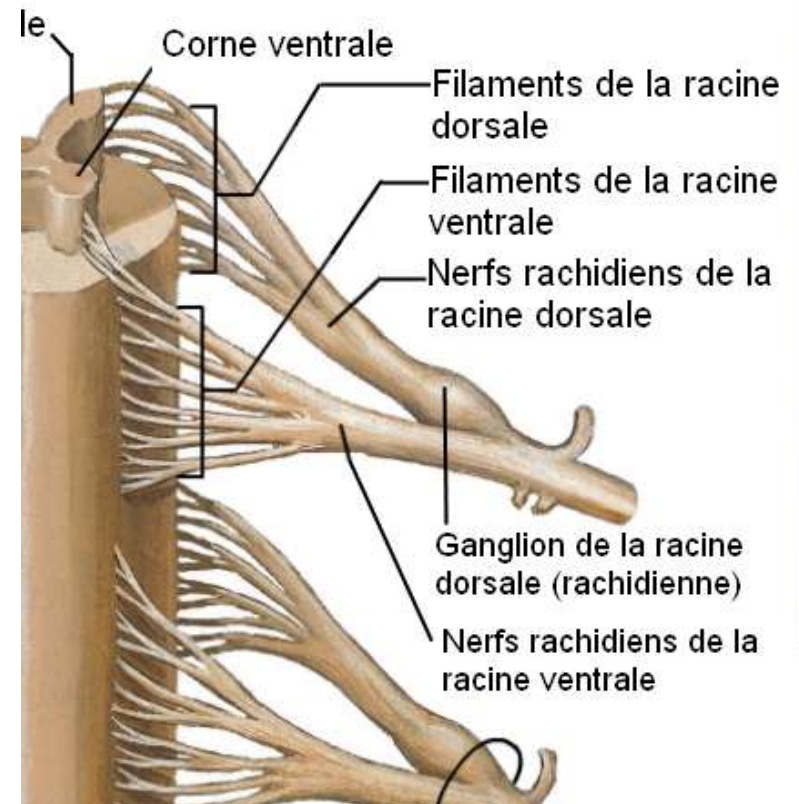
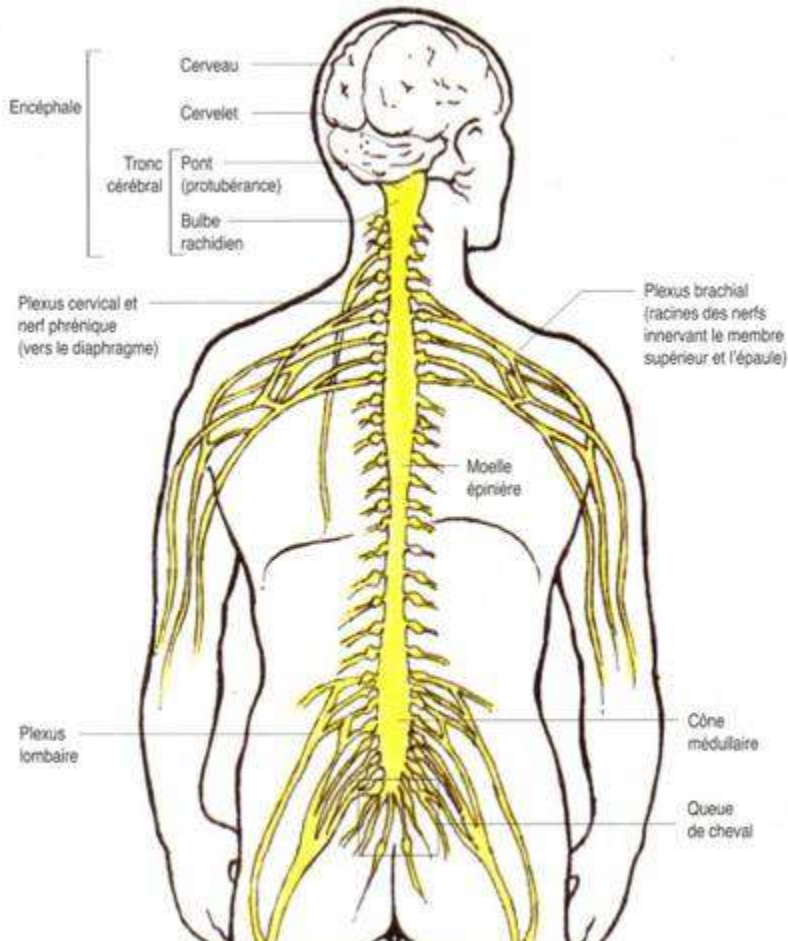
Ils assurent la motricité, la sensibilité et les fonctions végétatives du reste du corps.

[S.42]



La moelle épinière :
disposition générale dans le canal vertébral

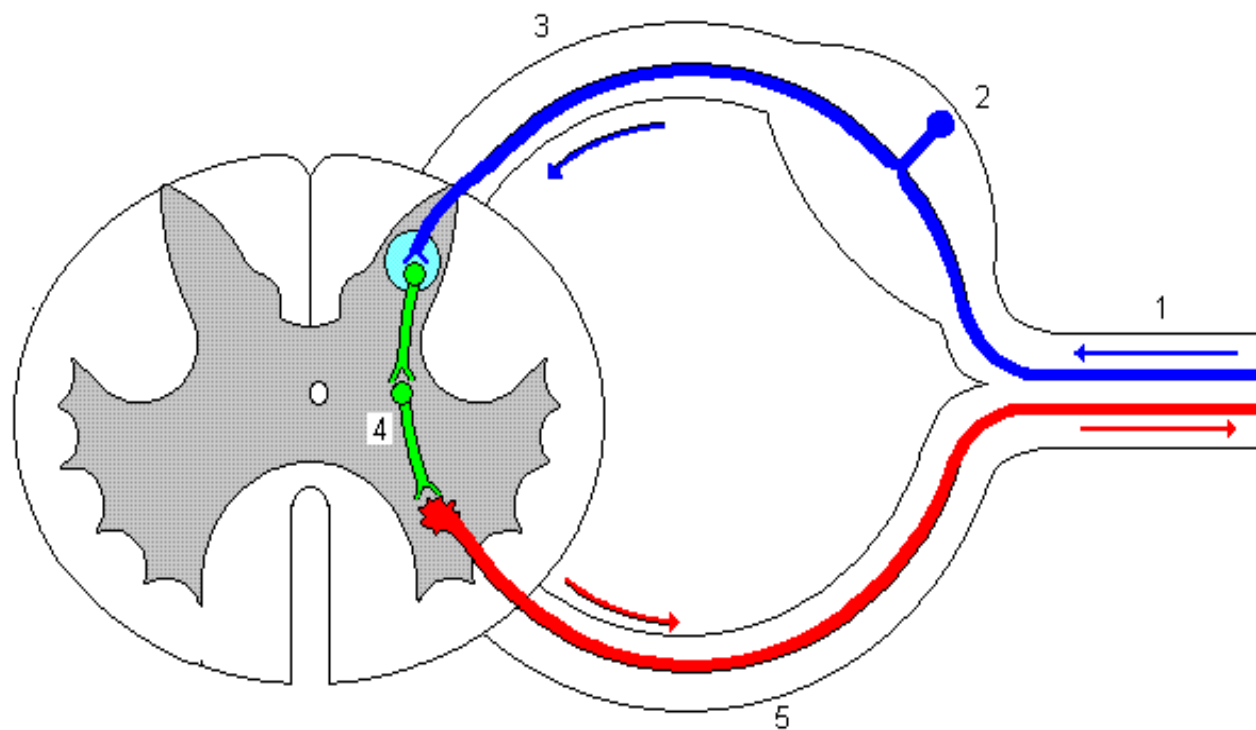
RAPPEL ANATOMIQUE (2)



La partie la plus proximale du SNP qui assure son émergence au SNC

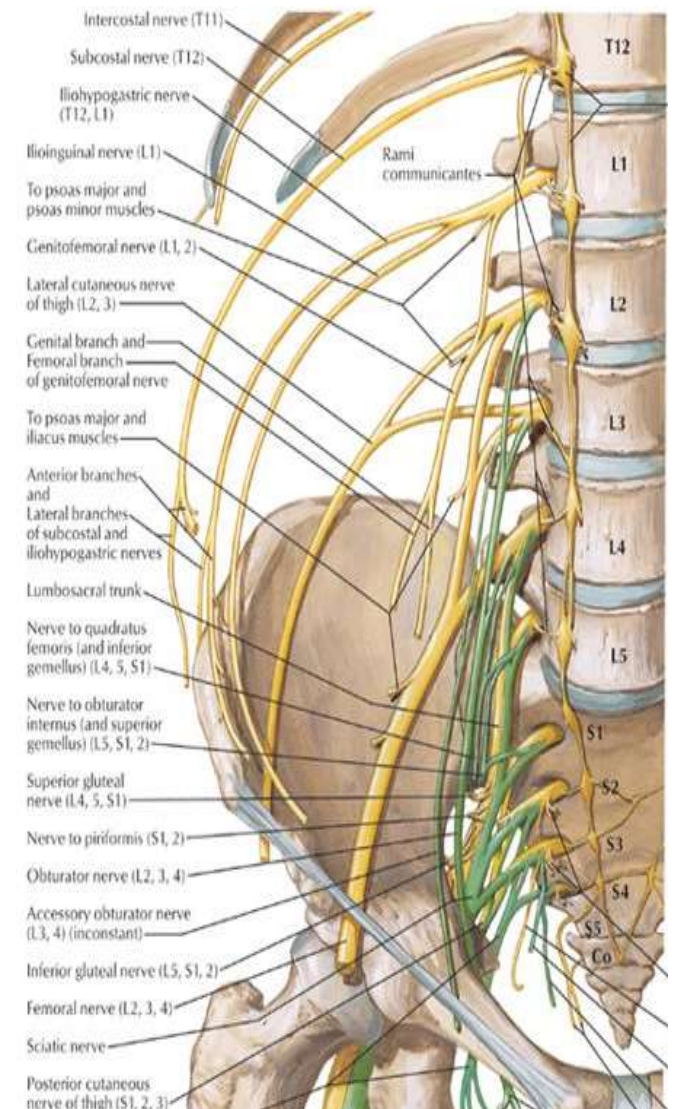
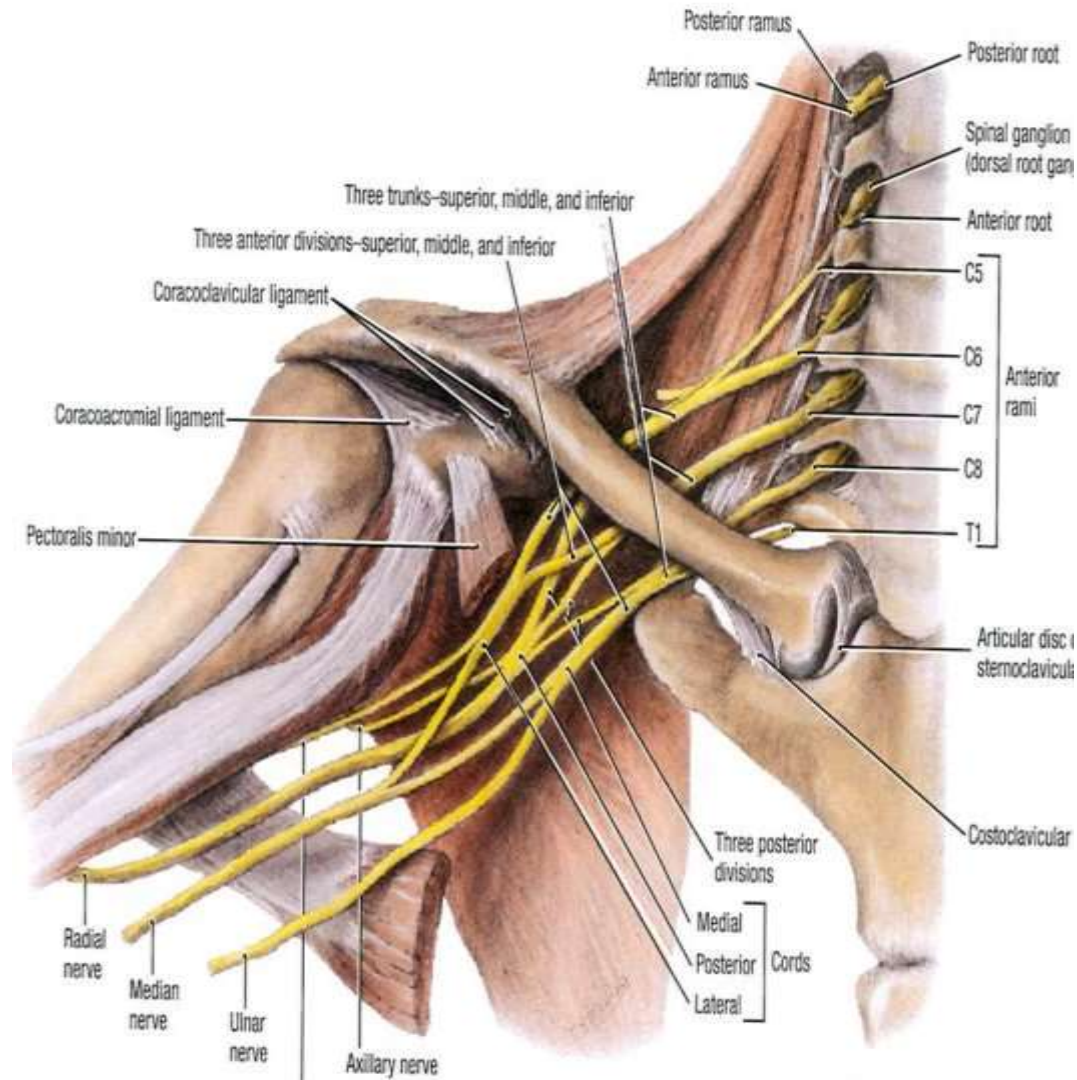
[S.55]

Arc réflexe de niveau médullaire segmentaire



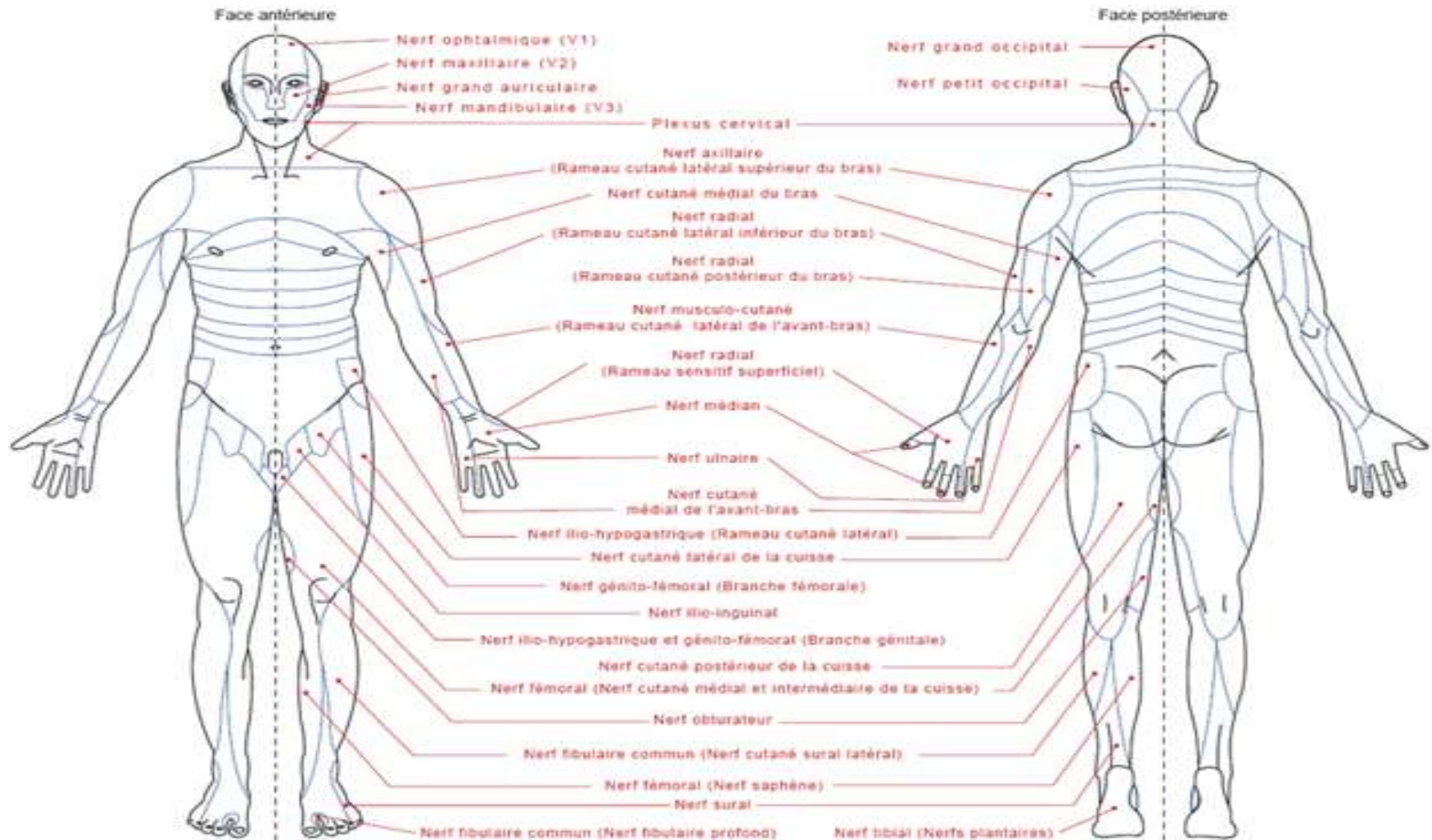
1 - Nerf Spinal (ou rachidien) - Nerf mixte 2 - Ganglion spinal 3 - Racine dorsale (sensitive)

4 - Inter - neurones (un ou plusieurs) 5 - racine ventrale (motrice)



Puis les racines se réunissent entre eux pour former les deux plexus (brachial et lombo-sacré)

RAPPEL ANATOMIQUE (4)



SYNDROME TOPOGRAPHIQUE (1)

SYNDROMES TOPOGRAPHIQUES DU
SYSTÈME NERVEUX PERIPHERIQUE

```
graph TD; A[SYNDROMES TOPOGRAPHIQUES DU SYSTÈME NERVEUX PERIPHERIQUE] --> B[SYNDROME REDICULAIRE]; A --> C[SYNDROME PLEXUEL]; A --> D[SYNDROME TRONCULAIRE];
```

SYNDROME
REDICULAIRE

SYNDROME
PLEXUEL

SYNDROME
TRONCULAIRE

SYNDROMES TOPOGRAPHIQUES DU SYSTÈME NERVEUX PERIPHERIQUE

```
graph TD; A[SYNDROMES TOPOGRAPHIQUES DU  
SYSTÈME NERVEUX PERIPHERIQUE] --> B[SYNDROME  
RADICULAIRE]
```

SYNDROME
RADICULAIRE

SYNDROME RADICULAIRE

1. TROUBLES MOTEURS:

- Sont très discrets.
- Une racine innerve plusieurs muscles et chaque muscle est innervé par plusieurs racines.
- Mais il existe des muscles dont l'innervation prédominante se fait à partir d'une seule racine: Muscles Indicateurs

C5 → Deltoïde.

L3 → Quadriceps.

C6 → Biceps.

L4 → Jambier antérieur.

C7 → Triceps + éminence Thénar.

L5 → Extenseur propre GO.

C8 → Éminence Hypothénar.

S1 → Muscles Péroniers.

SYNDROME RADICULAIRE

2. TROUBLES SENSITIFS:

- Sont très importants,
- Ils sont dominés par les troubles sensitifs subjectifs à type de douleur dont le trajet est caractéristique, qui est provoquée ou augmentée par :
 - Les manœuvres qui augmentent la pression dans le liquide céphalo-rachidien (la toux, la défécation).
 - Les manœuvres d'élongation de la racine par exemple la manœuvre de Lasègue en cas de sciatique.
- Les troubles sensitifs objectifs sont discrets voir absents.

SYNDROME RADICULAIRE

3. TROUBLES DES RÉFLEXES:

- Les réflexes sont diminués ou abolis en cas d'atteinte des racines concernées.

C5 → Bicipital.

C6 → Stylo-Radial.

C7 → Tricipital.

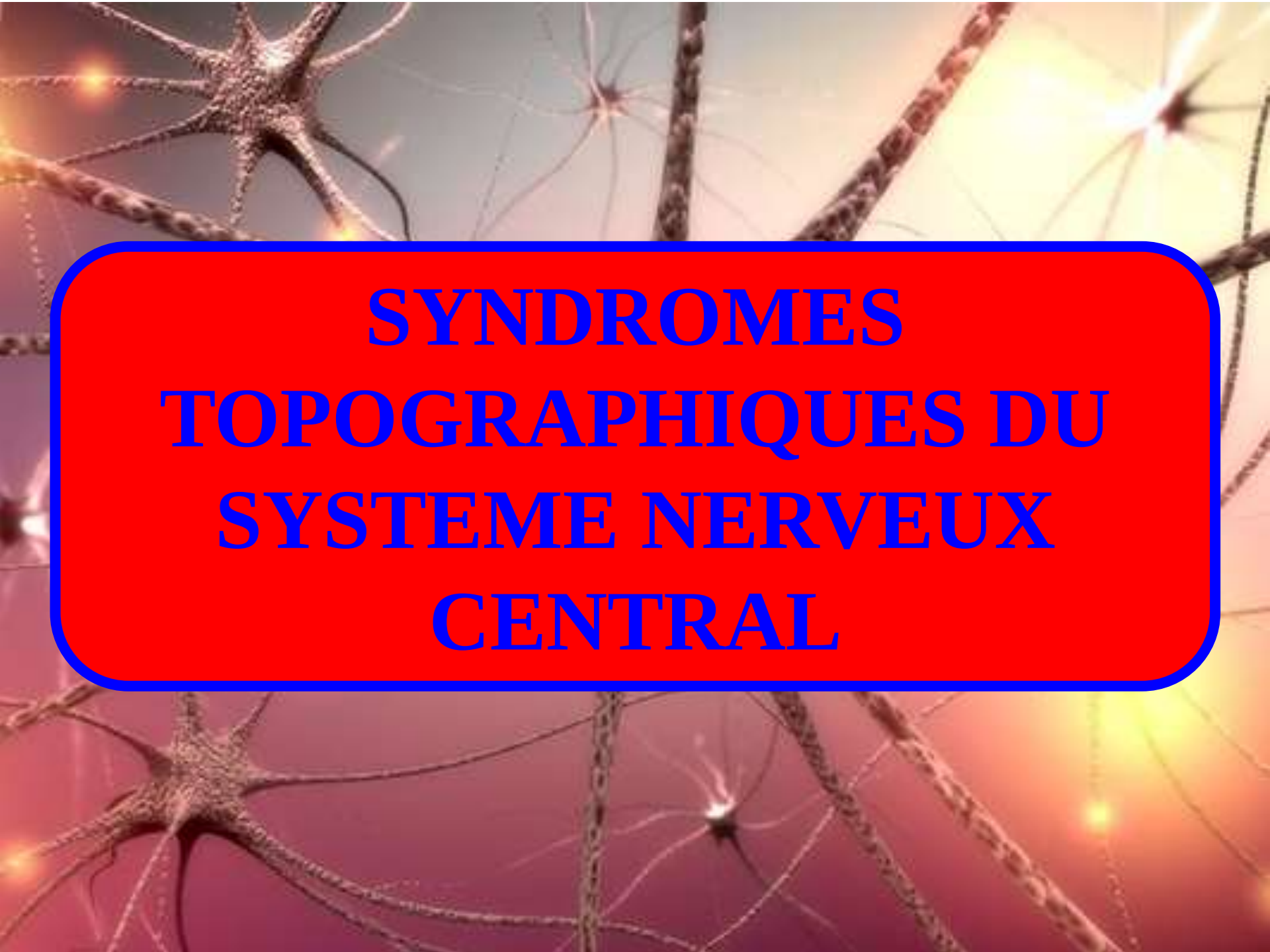
C8 → prono-cubital.

L3 → Rotulien

S1 → Achilléen

SYNDROME RADICULAIRE

- SYNDROME DE QUEUE DE CHEVAL:
- Atteinte pluri-radriculaire (L2-S5).
- Douleur : irradie le long des territoires correspondants.
- Déficit moteur et aréflexie $\equiv$ Racines touchées.
- Anesthésie en selle (région péri-anale).
- Impuissance sexuelle.
- Troubles sphinctériens type rétention ou incontinence.

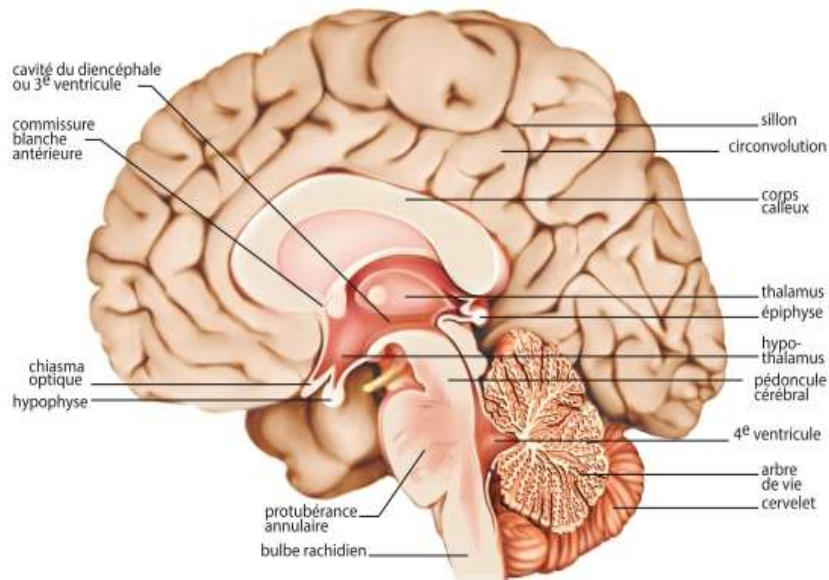
A microscopic view of neurons, showing their cell bodies and branching processes. Some synapses are highlighted with bright, glowing light effects, suggesting neural activity. The background is a soft, warm gradient of orange and yellow.

SYNDROMES TOPOGRAPHIQUES DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL

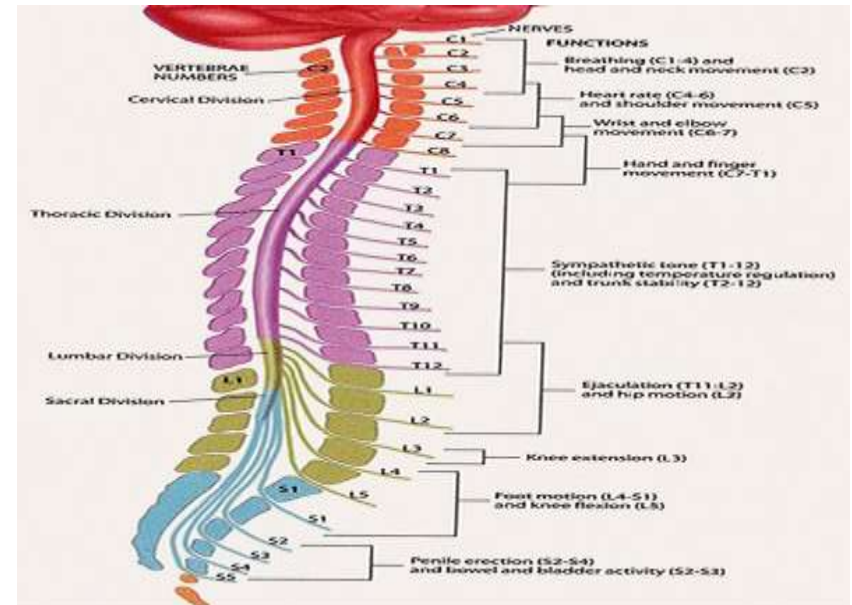
RAPPEL ANATOMIQUE

SYSTÈME NERVEUX CENTRAL

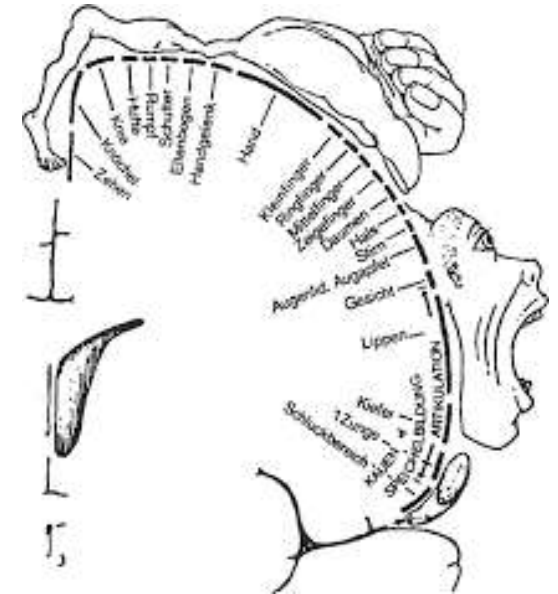
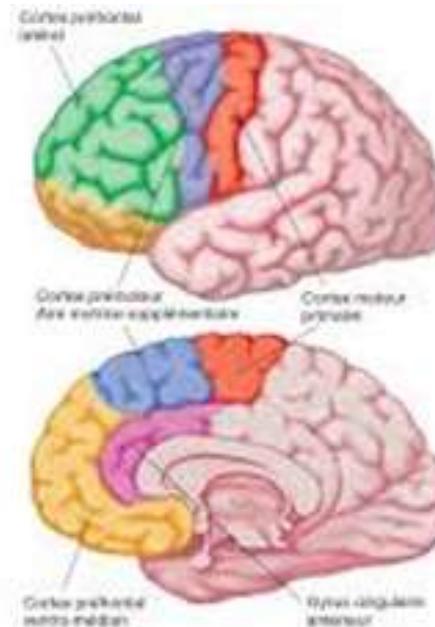
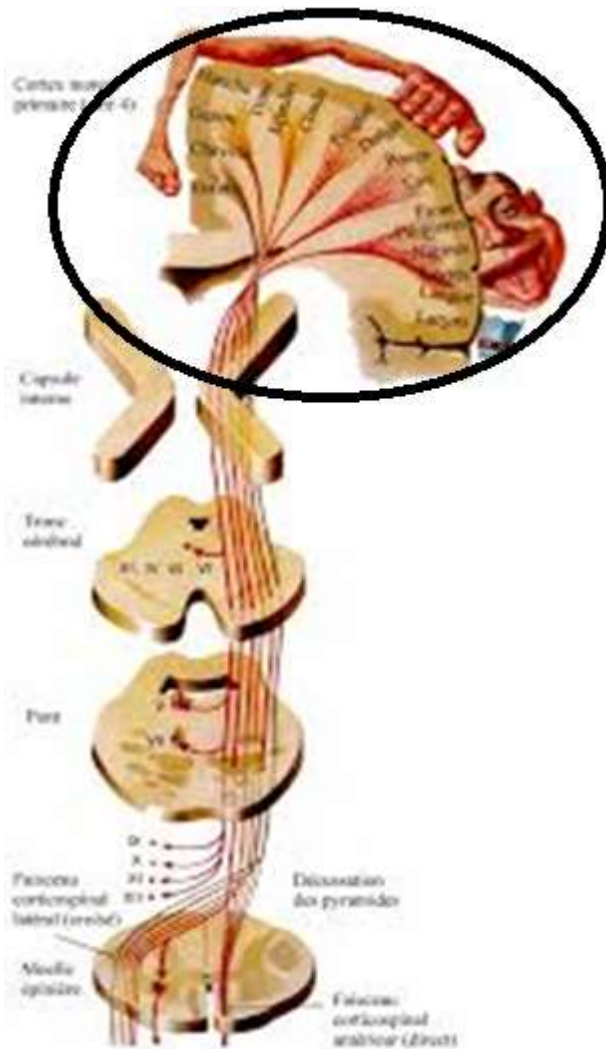
ENCÉPHALE



MOELLE ÉPINIÈRE

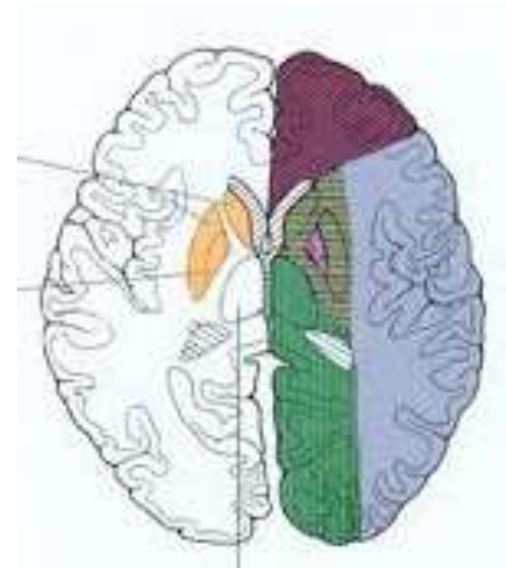
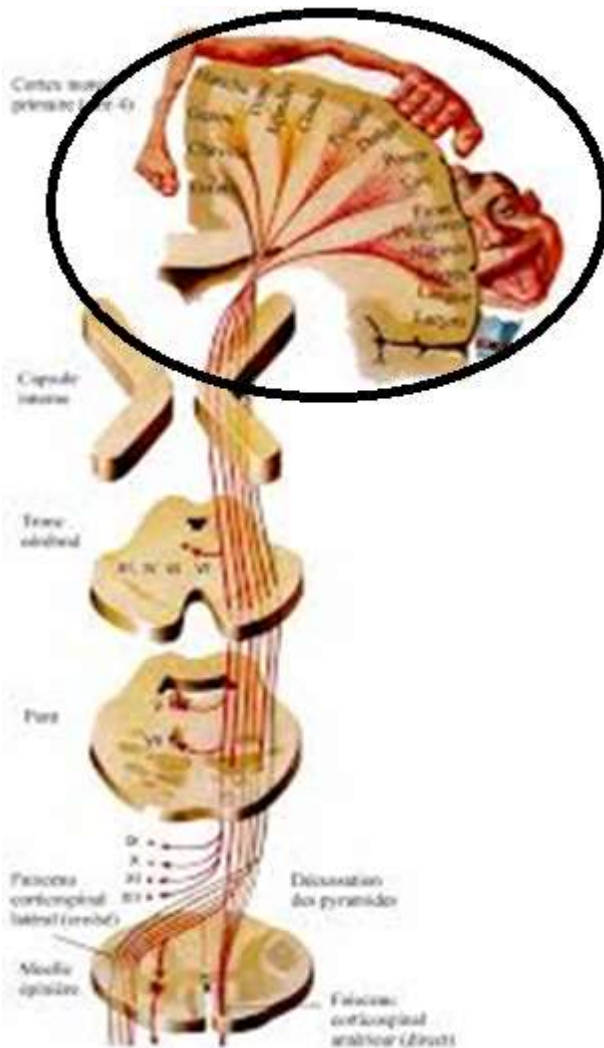


VOIE PYRAMIDALE



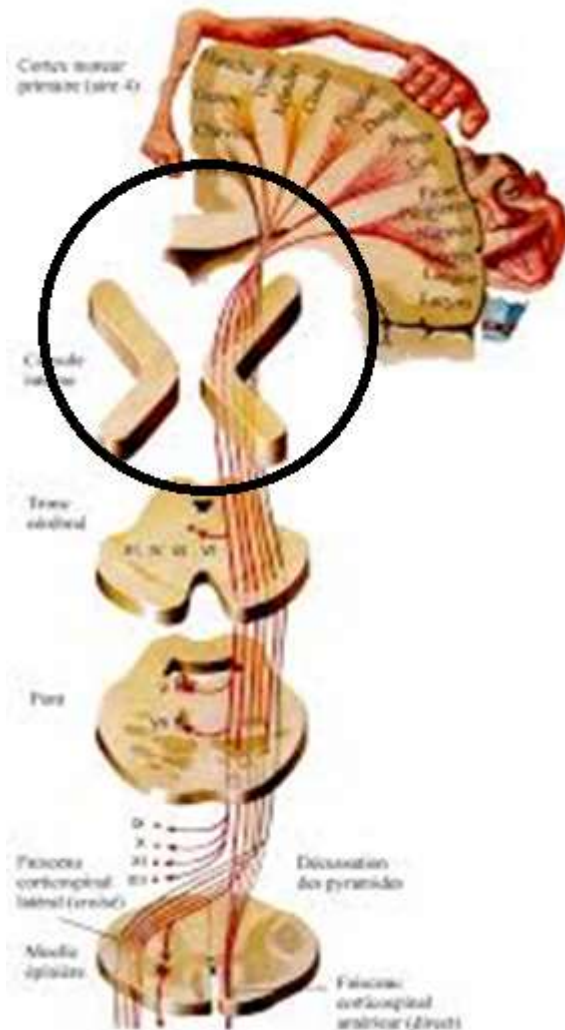
Il existe une somatotopie motrice bien individualisée (homonculus de Benfield) puisque: la région la plus basse est la région de la face puis vous avez au-dessus les commandes centrales de la main qui sont très développés puis le centre qui commande les muscles du bras et du tronc qui sont moins développées, Enfin, le centre du MI dans le lobule paracentral,

A) VOIE PYRAMIDALE (2)



Rappelez-vous que la face interne est vascularisée par l'artère cérébrale antérieure et donc l'atteinte de cette artère donne une sémiologie crurale par contre dans l'atteinte de l'artère cérébrale moyenne dans sa branche superficielle se manifeste par une sémiologie brachio-faciale.

A) VOIE PYRAMIDALE (3)

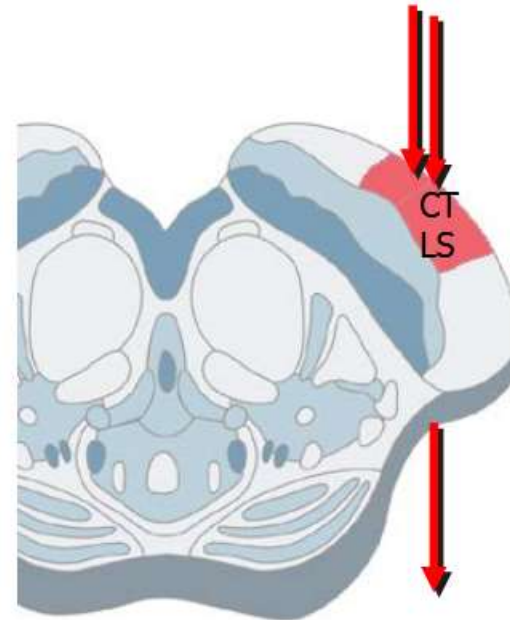
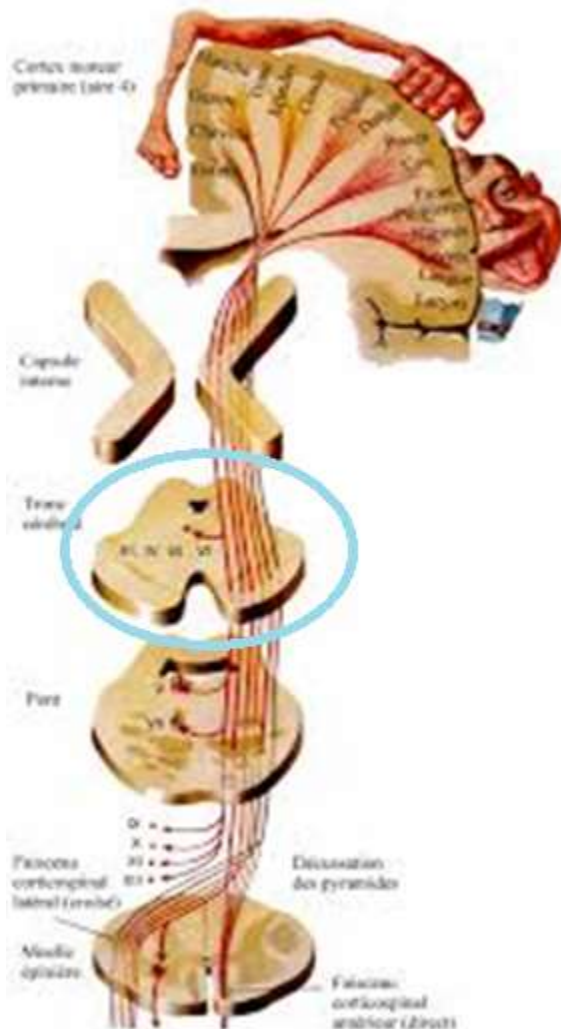


Légende :

- A : Cortex
- B : Noyau caudé
- C : Noyau lenticulaire
- D : Claustrum
- E : Thalamus
- F : Capsule interne
- G : Genou de la capsule interne
- H : Bras postérieur de la capsule interne

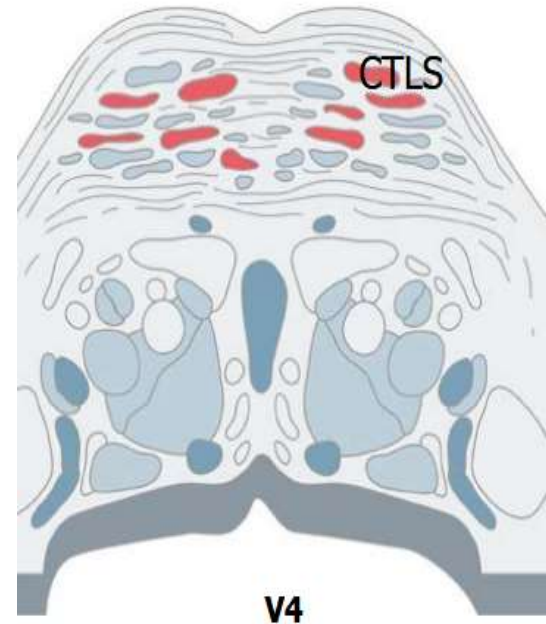
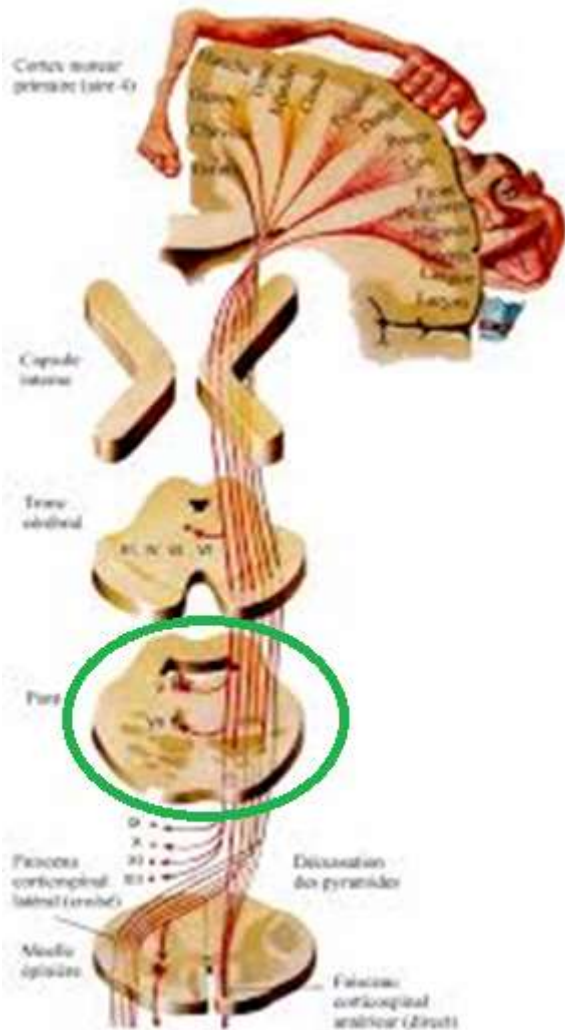
Je dois vous signaler que les voies qui assurent la motricité des membres passent dans le bras postérieur de la capsule interne alors que les voies destinées à la face passent dans le genou de la capsule

A) VOIE PYRAMIDALE (4)



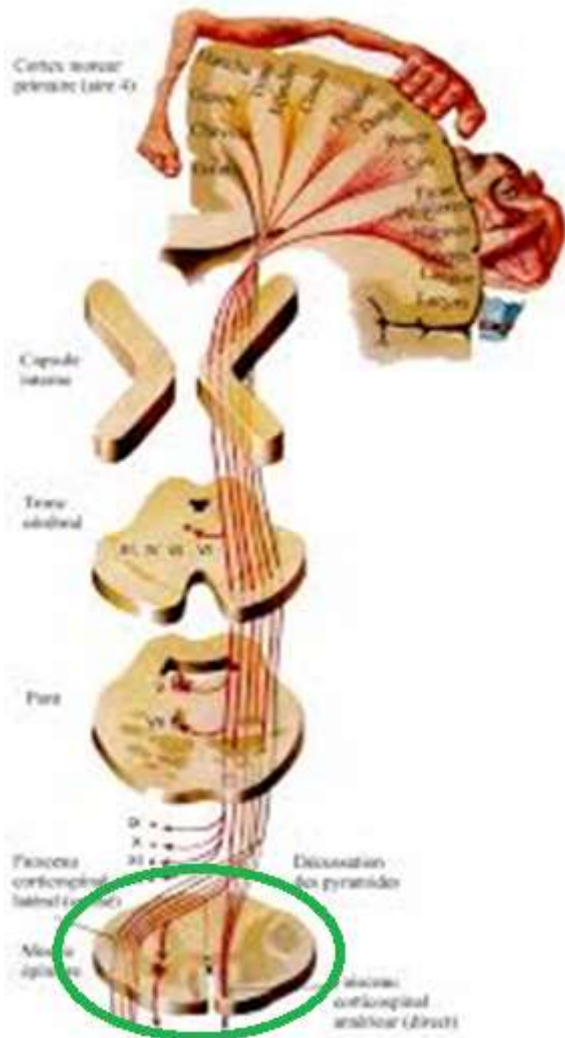
Puis les voies vont continuer de descendre dans le tronc cérébral, mais je dois vous mentionner que les voies pyramidales descendent toujours dans le pied de tronc cérébral qui est la partie antérieure.

A) VOIE PYRAMIDALE (5)



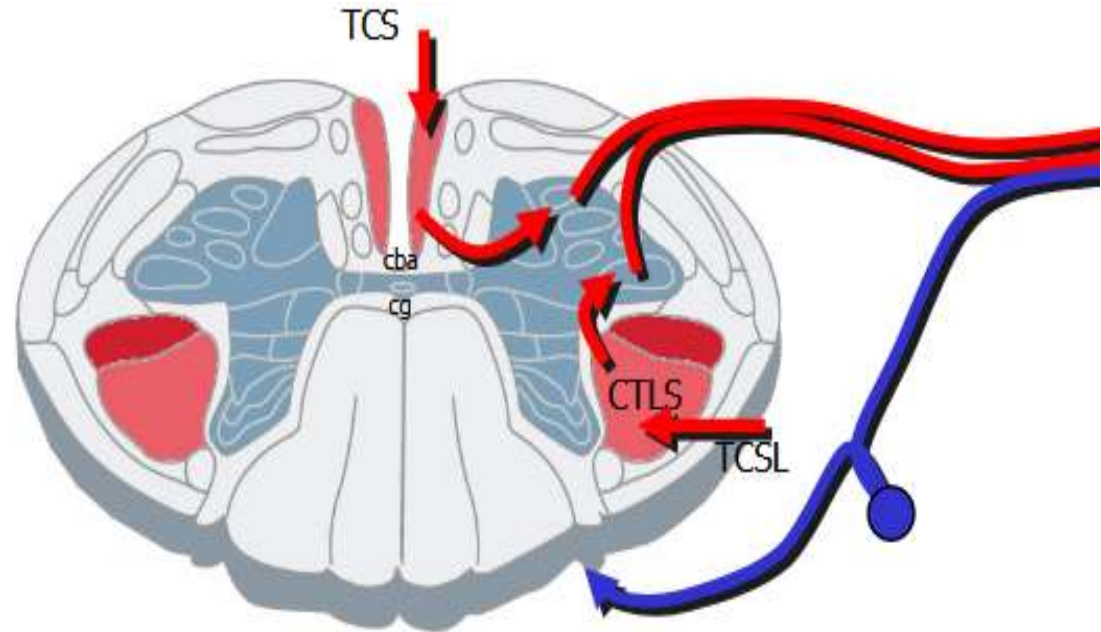
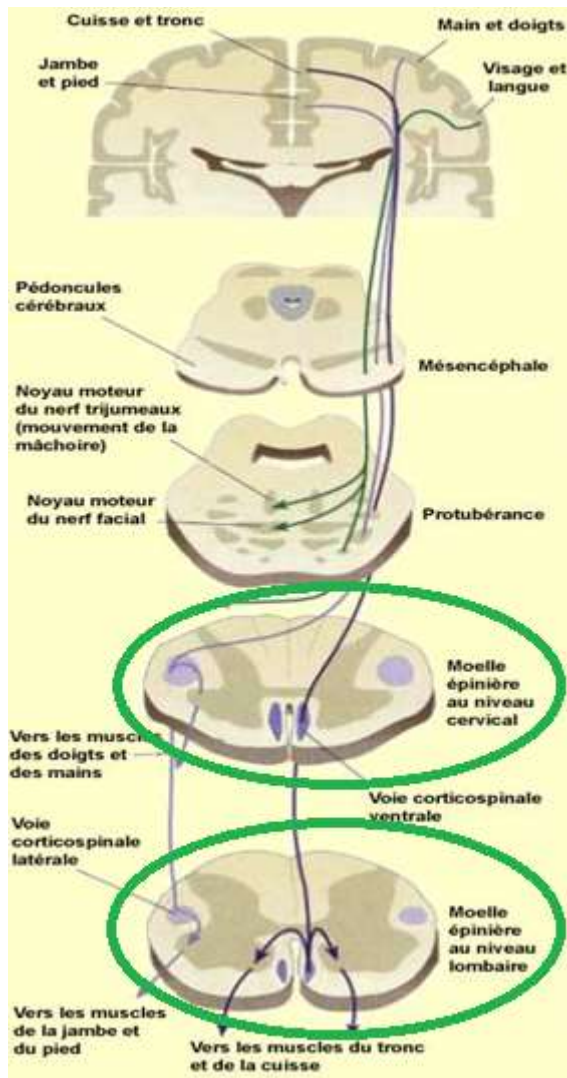
Puis les voies vont continuer de descendre dans le tronc cérébral, mais je dois vous mentionner que les voies pyramidales descendent toujours dans le pied de tronc cérébral qui est la partie antérieure.

A) VOIE PYRAMIDALE (6)



La voie pyramidale croise la ligne médiane au niveau du bulbe bas (environ 90% des fibres croisent la ligne médiane formant alors la voie cortico-spinale croisée). Les autres 10% restent du même côté pour former la voie cortico-spinale directe.

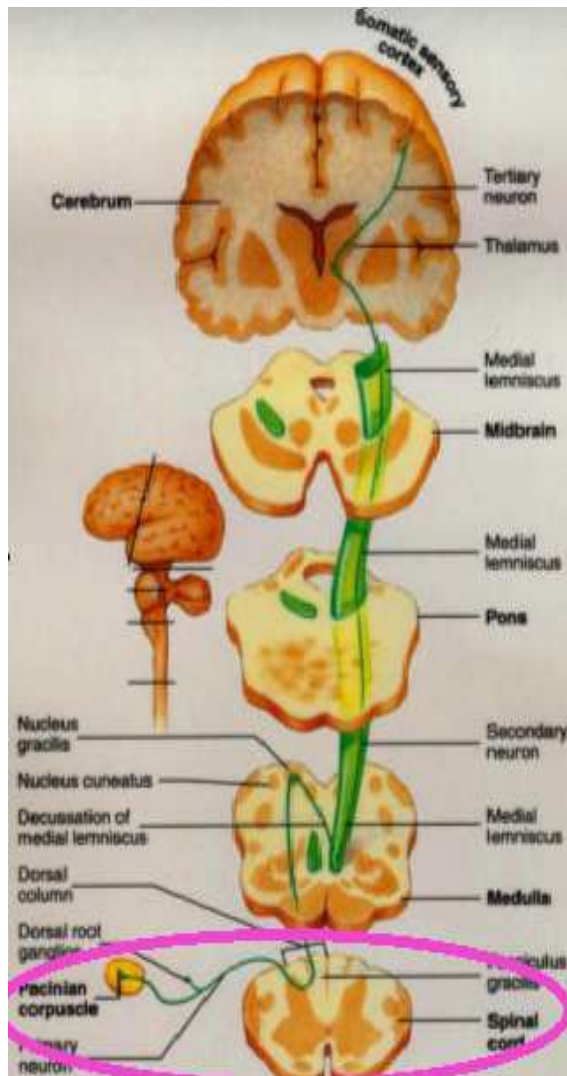
A) VOIE PYRAMIDALE (7)



La voie cortico-spinale directe descend du même coté dans le cordon antérieur de la moelle.

A chaque segment, elle se termine sur les colonnes de motoneurones les plus internes. Elle a pour cible les muscles axiaux.

VOIE DU CORDON POSTERIEUR (1)



Voies sensorielles ascendantes

Voie cordonale postérieure

Faisceau gracile

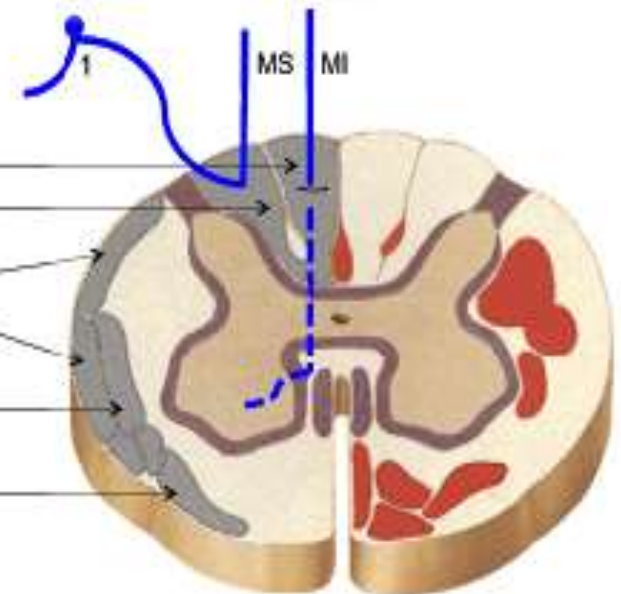
Faisceau cunéiforme

Faisceaux spino-cérébelleux

Cordons antéro-latéraux

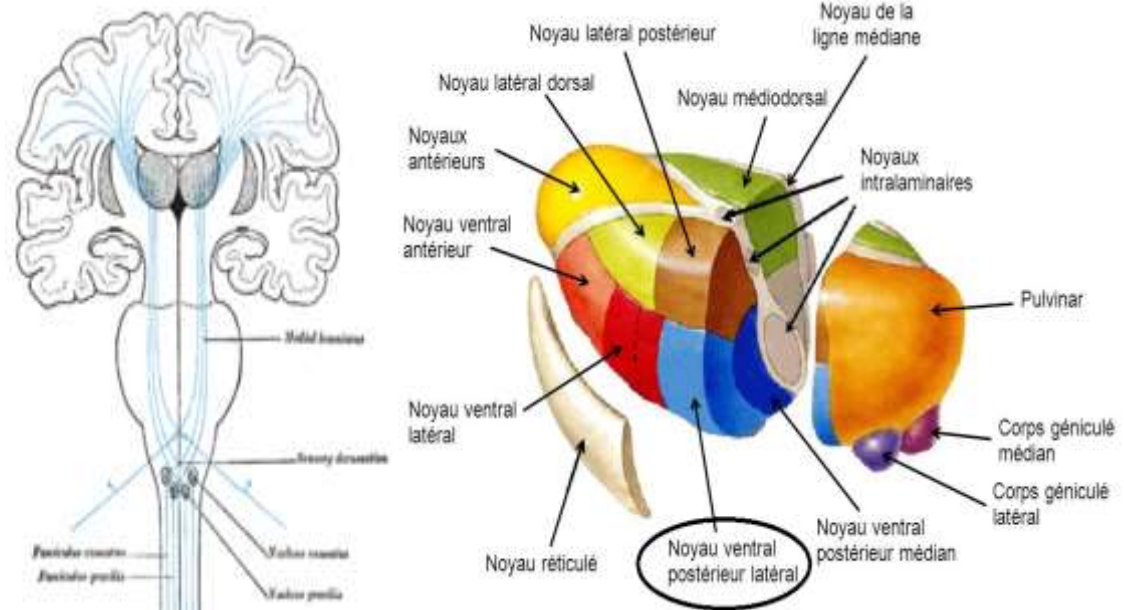
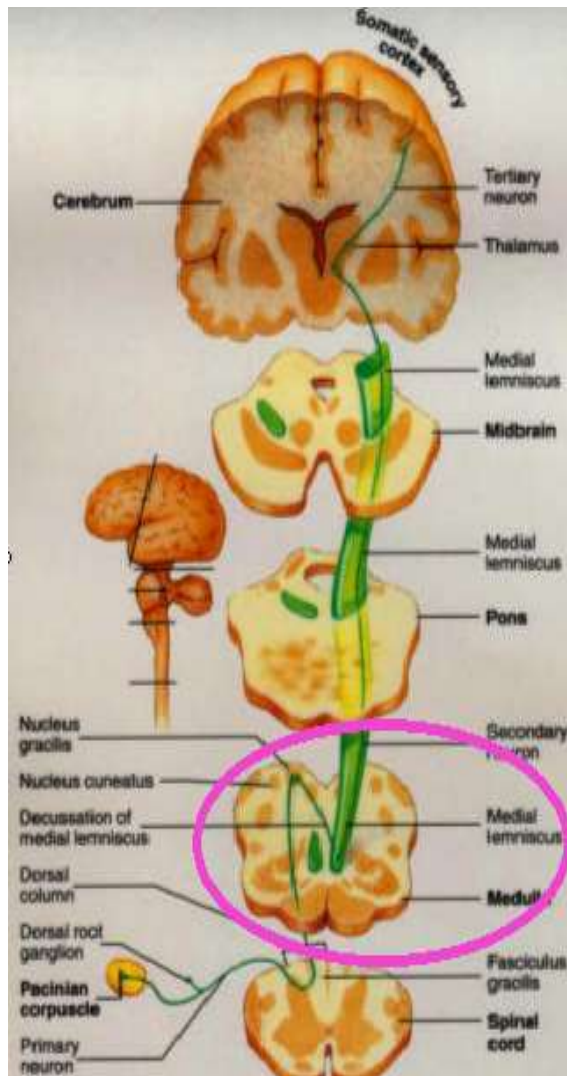
Faisceau spino-thalamique latéral

Faisceau spino-thalamique médian



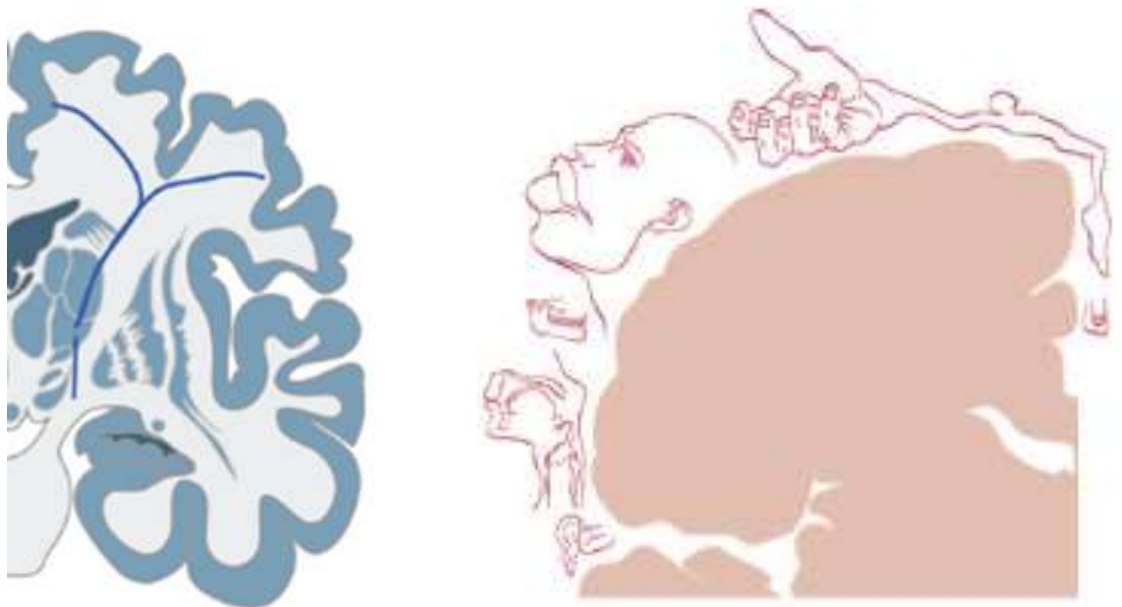
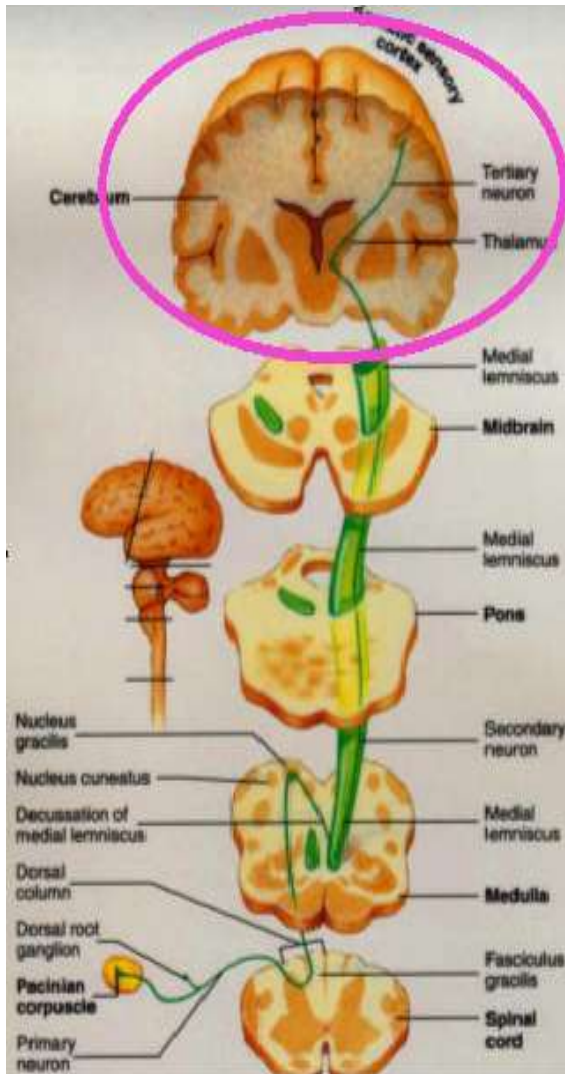
Dans la ME les fibres montent dans le cordon post homolatéral formant 02 faisceaux : partie interne (faisceau gracile) véhiculant les informations venant de la partie inf du corps (Mb inf, petit bassin et tronc) Partie plus latérale (faisceau cunéiforme) véhiculant les informations venant de la partie sup du corps (Mb sup, partie sup du tronc, cou et occiput)

B) VOIE DU CORDON POSTERIER (2)

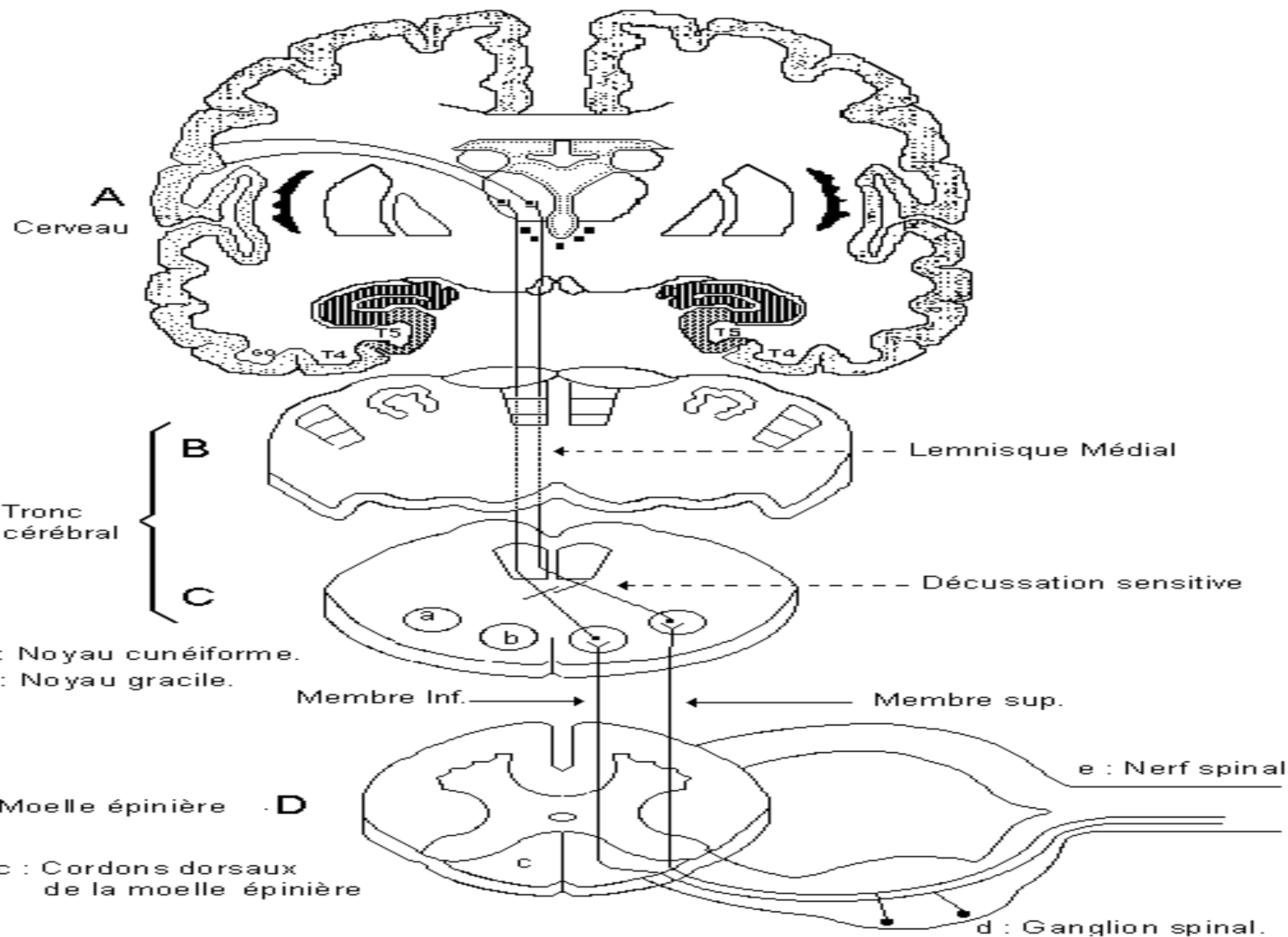


Dans le bulbe, le 1^{er} neurone s'articule à la jonction bulbo cervicale dans 2 noyaux : Noyau gracile (Goll) et cunéiforme (Burdach) avec le 2^{ème} neurone qui croise la ligne médiane à la partie inférieure du bulbe constituant le lemnisque médian qui monte dans le tronc cérébral en arrière du faisceau pyramidal et se termine dans le noyau VPL du thalamus

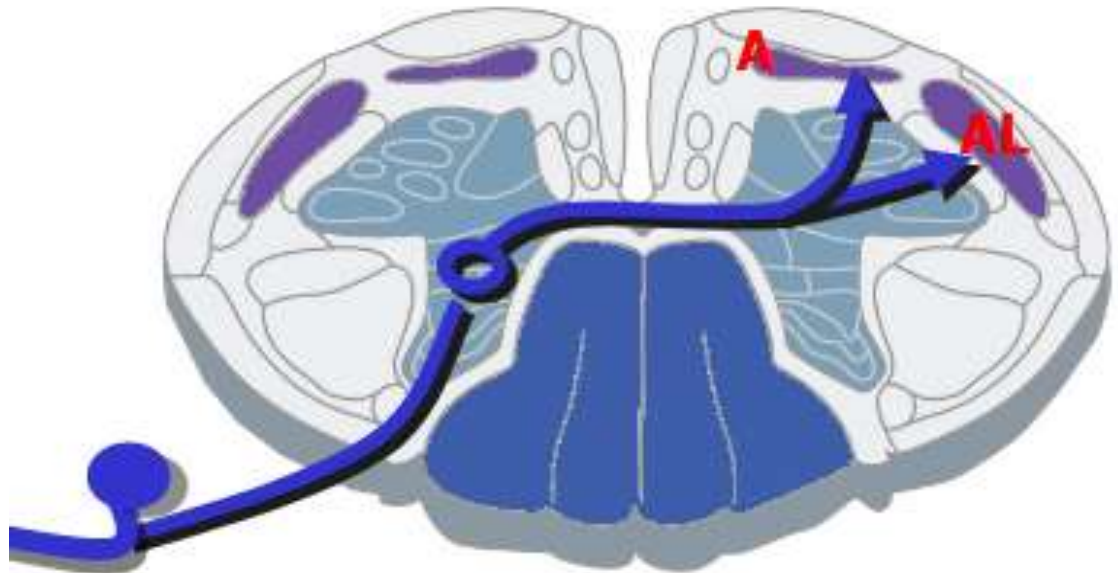
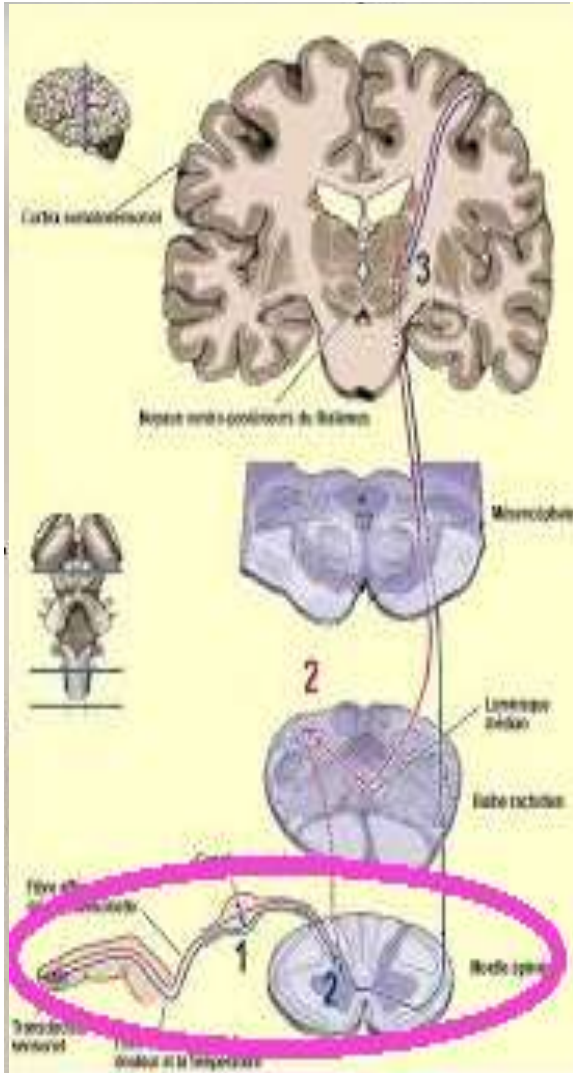
B) VOIE DU CORDON POSTERIER (3)



Du thalamus, le 3^{ème} neurone sensitif se projette au niveau de l'aire somesthésique primaire en arrière du sillon central correspondant aux aires : 1, 2, 3a, 3b de BRODMANN et operculaire. Il existe une somatotopie sensitive.

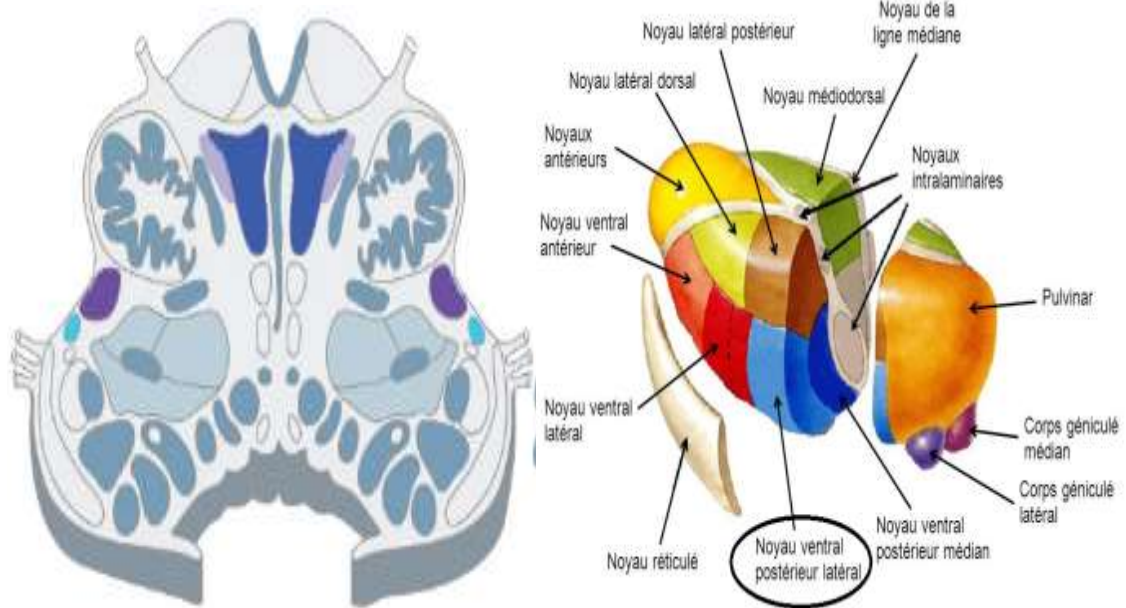
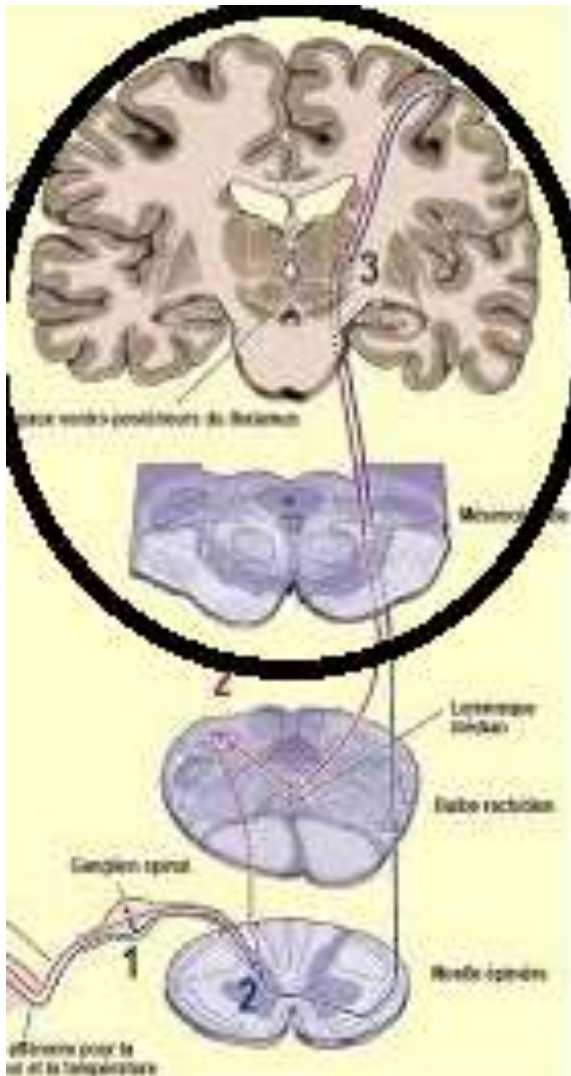


VOIE SPINOTHALAMIQUE (1)



Le deuxième neurone naît dans la corne post de la ME, croise la ligne médiane, passe en avant du canal épendymaire pour gagner le cordon antérolatérale de la ME formant le faisceau spino-thalamique, lui-même formé de 02 faisceaux : (Néospinothalamique et Spinoreticulothalamique)

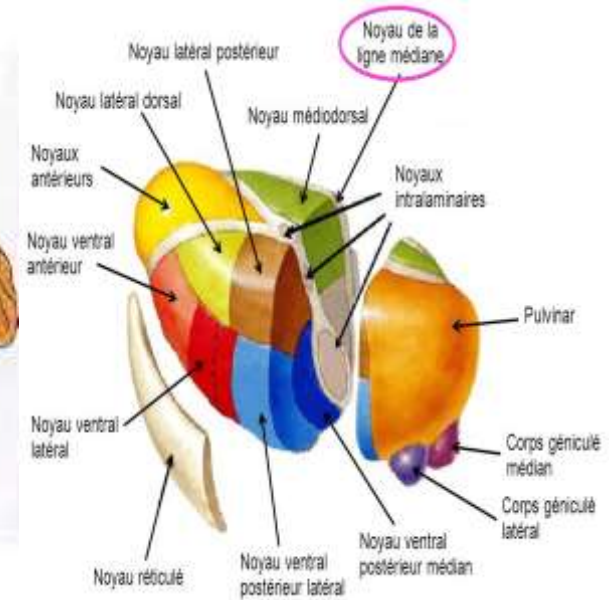
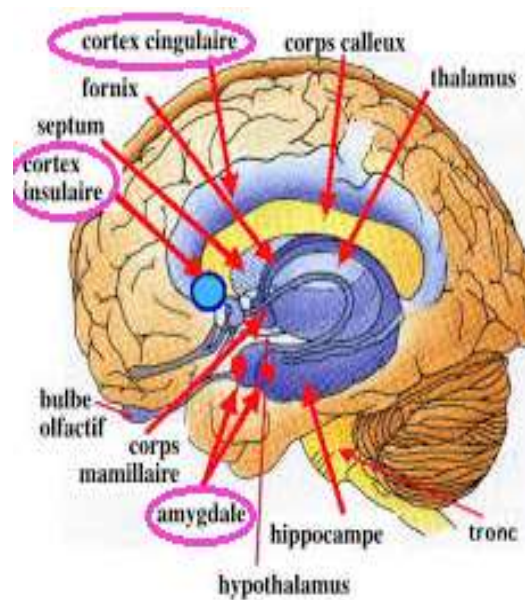
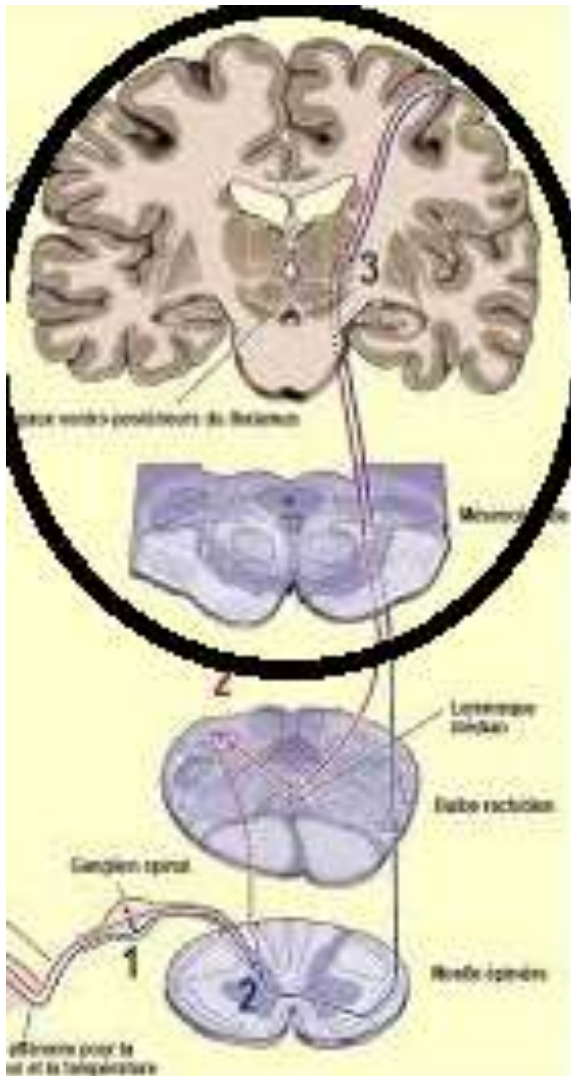
VOIE SPINOTHALAMIQUE (2)



Néospinothalamique :

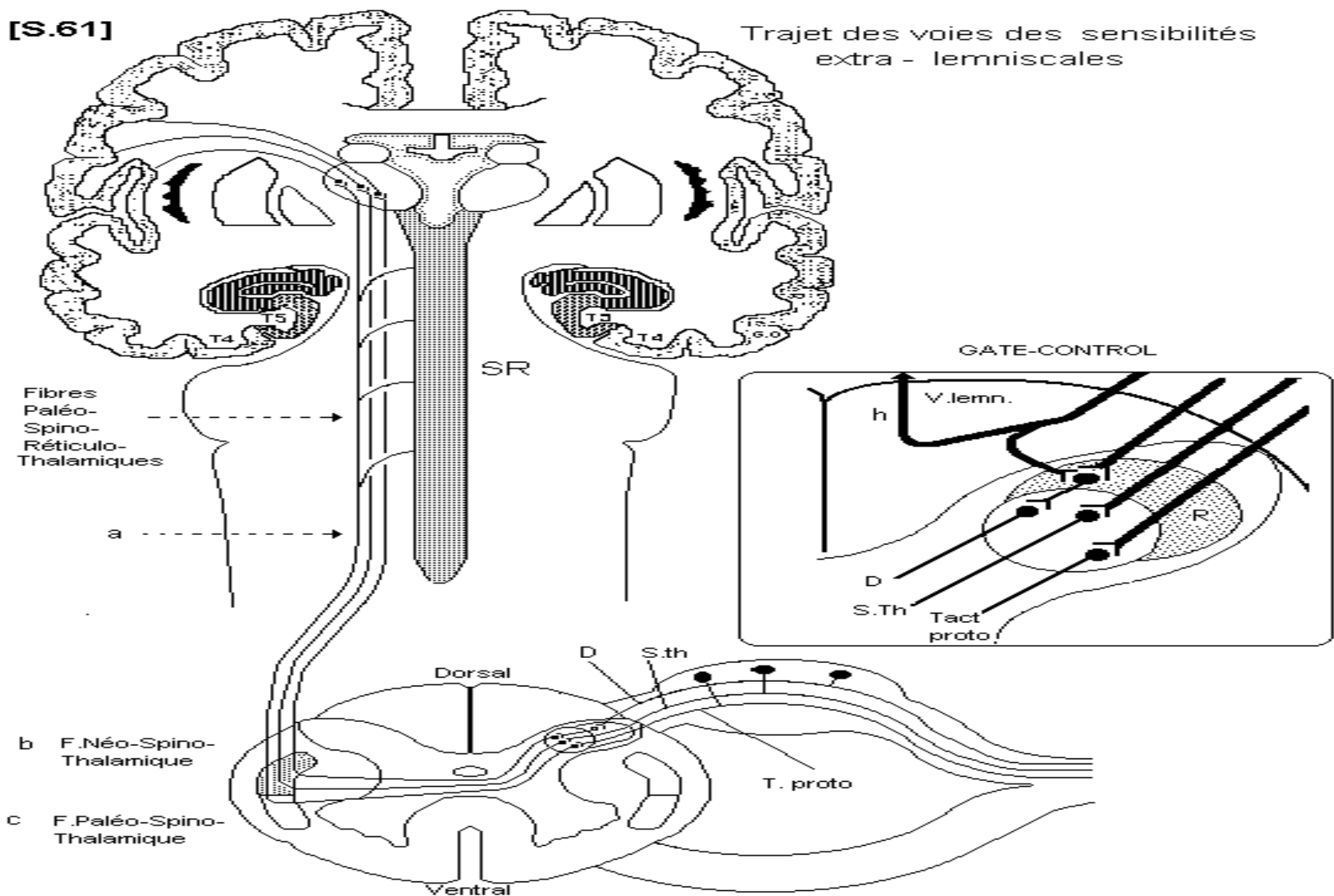
Après un trajet rétro-olivaire, ses fibres rejoignent le ruban de Reil médian, puis VPL. Le 3ème neurone naît au niveau du noyau VPL du thalamus et se termine au niveau de la PA (suit la voie lemniscale).

C) VOIE SPINOTHALAMIQUE (3)



Spinoreticulothalamique :

Se projette sur les noyaux réticulaires du TC (du bulbe : noyau gigantocellulaire, jusqu'au mésencéphale : substance grise péri-aquaducule, noyau cunéufomis), noyau médian du thalamus, puis sur le cortex frontal interne (gyrus cingulaire et l'amygdale).



a : Faisceau spino - thalamique (avec fibres collatérales spino - réticulo - thalamiques)

b : Faisceau Néo - spino - thalamique. c : Faisceau Paléo - spino - thalamique

D : fibres de la douleur. S.th. : fibres de la sensibilité thermique.

Tact proto: fibres du tact protopathique; g : substance réticulée. h : voies lemniscales

R : substance gélatineuse de Rolando. SR : Substance réticulée

V.lemn.: Voies lemniscales



SYNDROMES TOPOGRAPHIQUES DE LA MOELLE EPINIERE

SYNDROME MÉDULLAIRE (1)

1. TROUBLES MOTEURS:

- Se manifestent par un déficit de la force musculaire dont l'importance est variable.
- Il peut se présenter sous 02 aspects différents :

A. UN SYNDROME NEUROGÈNE PERIPHÉRIQUE :

- Il traduit une lésion des cornes ou des racines antérieures de la moelle.
- Il se manifeste par: amyotrophie, hypotonie et abolition des ROT

B. UN SYNDROME PYRAMIDAL:

- La paralysie peut être flasque dans les formes aiguës avec abolition des ROT, mais la constatation d'un signe de Babinski permet d'affirmer l'origine centrale,
- Elle est le plus souvent spastique dans les formes d'installation progressive ou après la phase aiguë (3-4 semaines).
- L'hypertonie musculaire est élastique, ROT vifs et Babinski.

SYNDROME MÉDULLAIRE (2)

2. LES TROUBLES SENSITIFS :

A. UN SYNDROME RADICULAIRE :

- Douleurs et hypoesthésie de même topographie traduit le niveau lésionnel.

B. LES SIGNES CORDONAUX :

- Il conviendra de préciser le caractère uni ou bilatéral et surtout le niveau supérieur de l'atteinte.

a. CORDON POSTERIEUR :

- Il se manifeste par l'altération des sensibilités profondes élémentaires et ataxies proprioceptives.

a. CORDON ANTERO-LATERAL :

- Il se manifeste par l'altération des sensibilités tactile et thermo-algésiques.
- Leur limite supérieure traduit le niveau de la lésion.

SYNDROME MÉDULLAIRE (3)

3. TROUBLES VÉGÉTATIFS :

- Le trouble observé sera différent selon le niveau de l'atteinte :
 - Syndrome de Claude-Bernard-Horner par une lésion de C8-D1, qui se manifeste par la triade : ptosis, myosis et énophtalmie.
 - Troubles sphinctériens vésicaux par une lésion au niveau S3-S4.



1) SYNDROME MÉDULLAIRE (4)

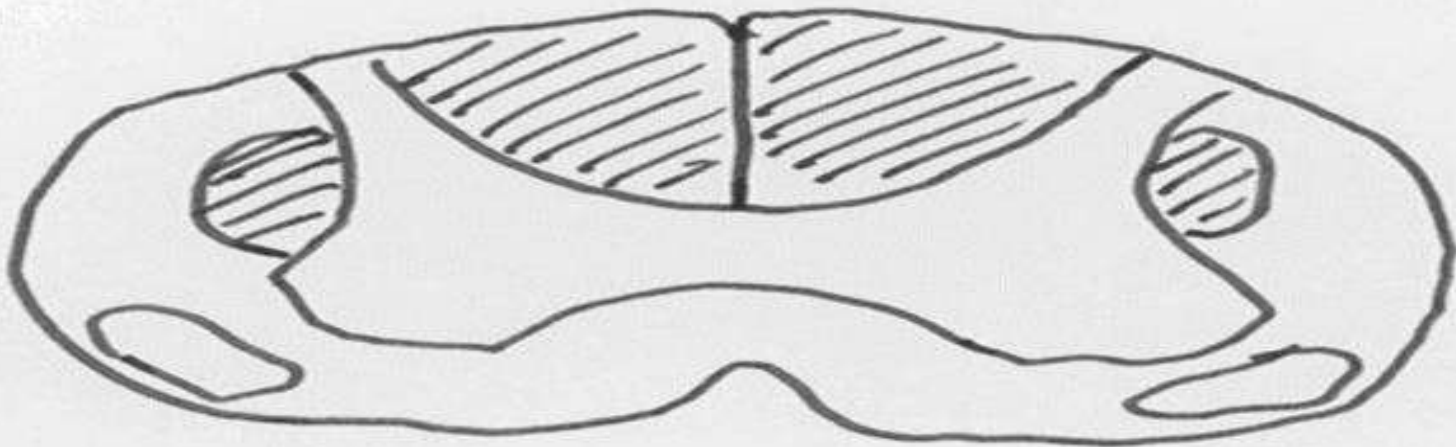
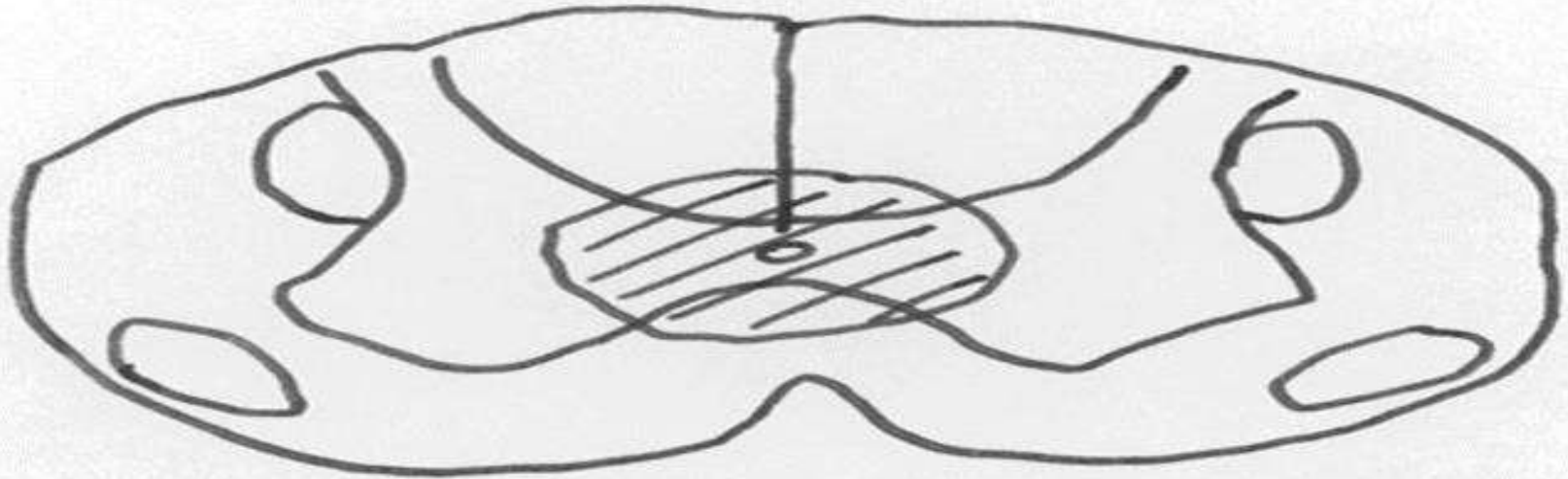
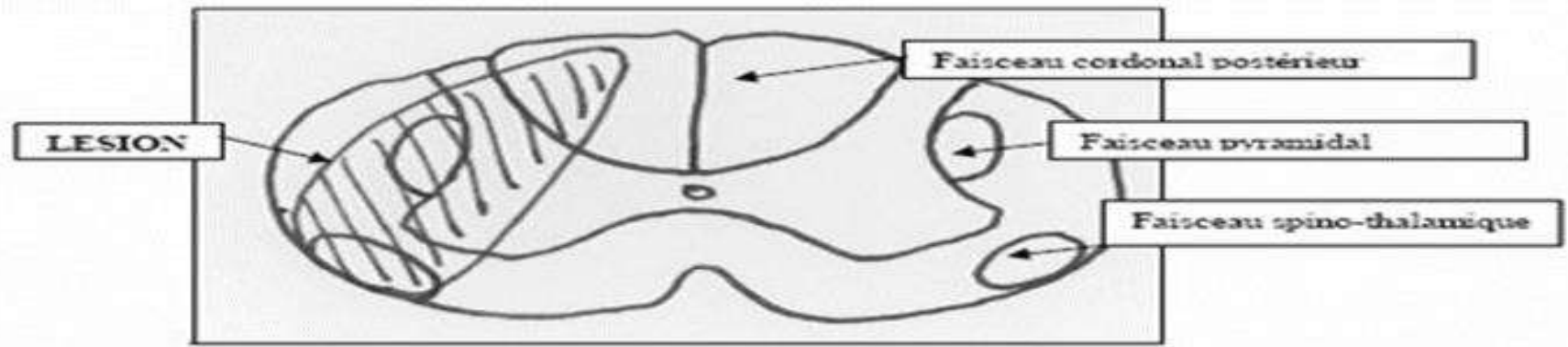
1. SYNDROME HÉMI-MOELLE (SYNDROME BROWN-SÉQUARD):

- Du côté de la lésion :
 - Un syndrome pyramidal.
 - Une abolition de la sensibilité profonde et de la sensibilité tactile discriminative.
- Du côté opposé de la lésion :
 - Abolition de la sensibilité thermo-algésique.

1 SYNDROME MÉDULLAIRE (5)

2. SYNDROME CENTROMÉDULLAIRE (SYNDROME SYRINGOMYÉLIQUE:

- Se caractérise par l'existence dans un territoire *suspendu* en **bande** d'une atteinte **dissociée** de la sensibilité portant sur la **sensibilité thermo-algésique**.
- La lésion responsable siège dans la substance grise centro-médullaire interrompant les deuxièmes neurones de la sensibilité thermo-algésique dans leur trajet de la corne post vers le faisceau spino-thalamique controlatéral.



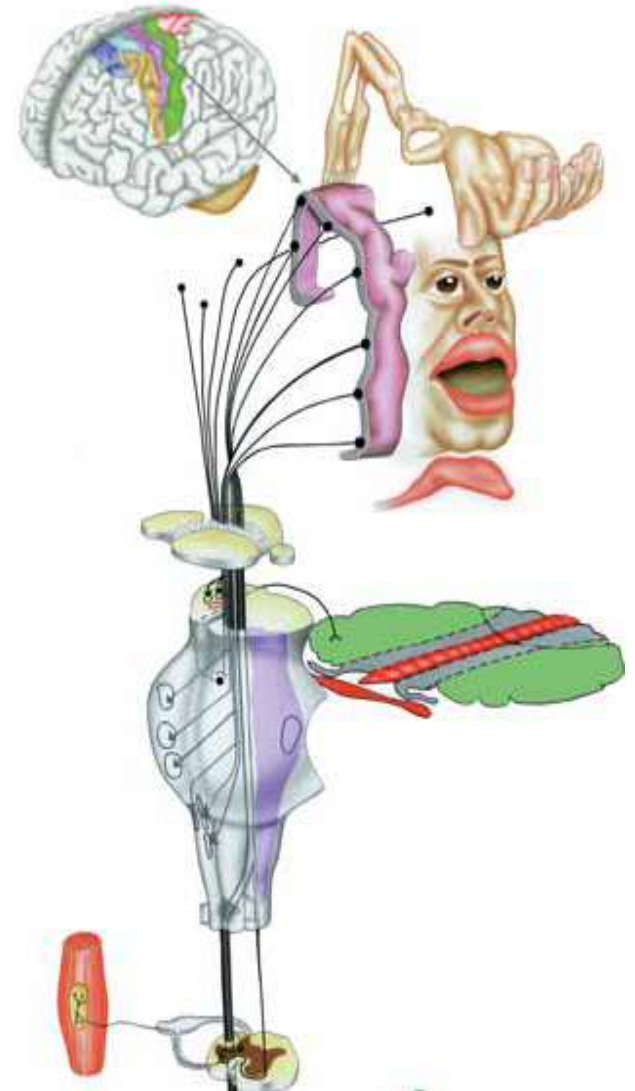
A microscopic image of neurons, showing several cell bodies with long, branching dendrites and axons. The background is a warm, golden-yellow color with some light flares. A large, red, rounded rectangular box with a blue border is centered over the image, containing the title text in blue, bold, serif capital letters.

SYNDROMES TOPOGRAPHIQUES DE L'ENCEPHALE

Diagnostic topographique

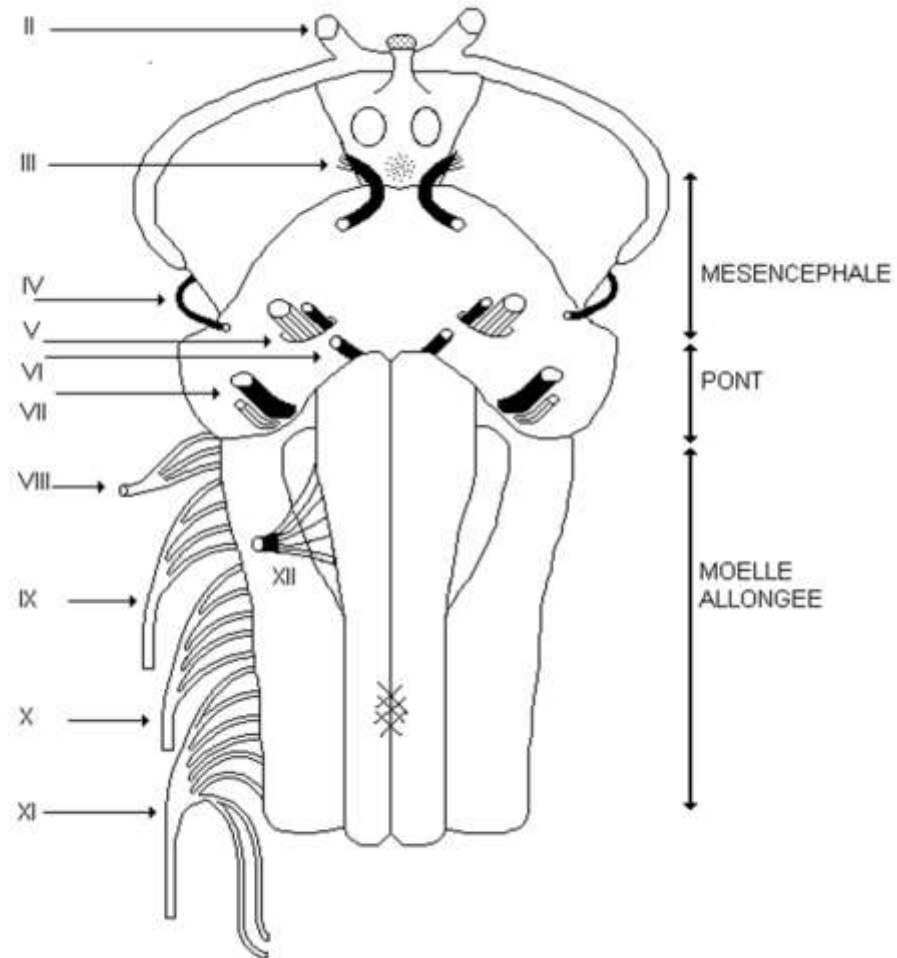
Atteinte du tronc cérébral :

- Les syndromes *alternes* associant :
 - Hémiplégie **controlatérale**.
 - Paralysie d'un ou de plusieurs **nerfs crâniens homolatéraux** à la lésion.

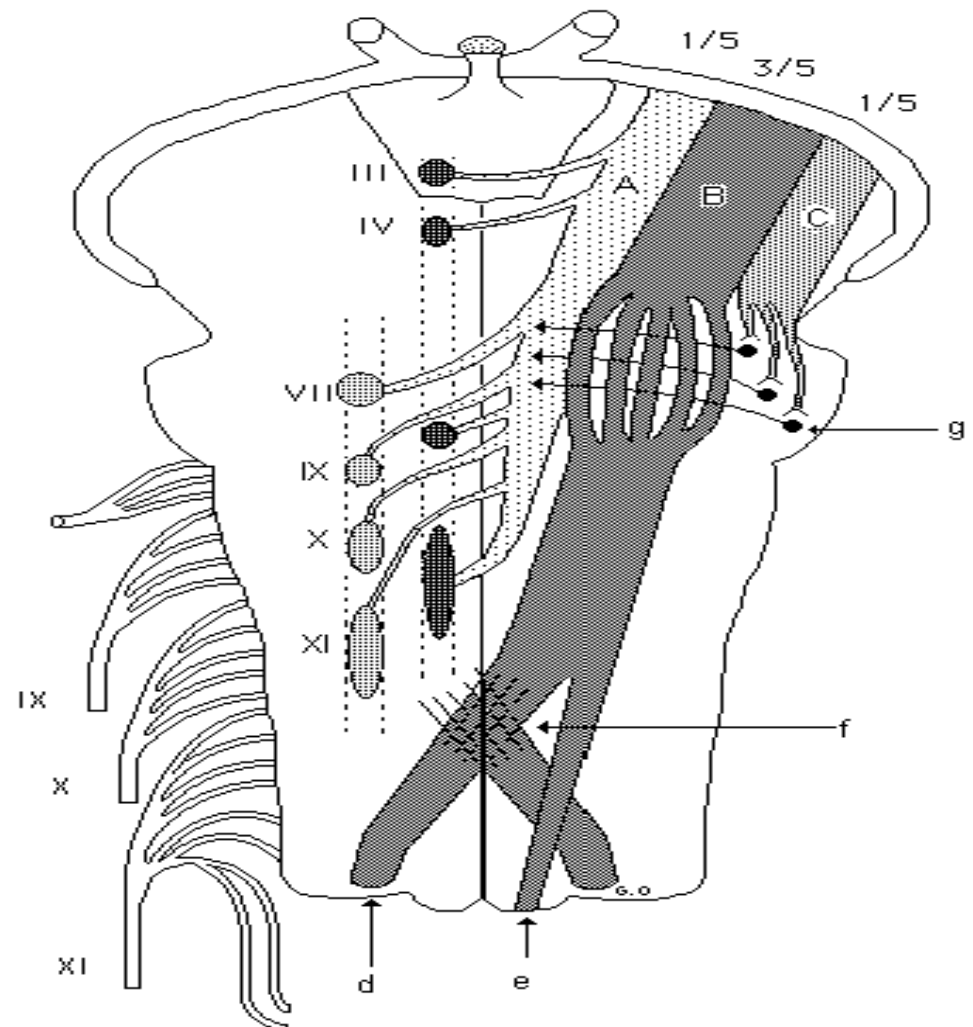


[S.76]

Les nerfs crâniens et le Tronc cérébral



[S.82] Tronc cérébral : Systématisation des voies de la motricité



A : Faisceau Géniculé. B : Faisceau Pyramidal.

C : Faisceau Cortico - Pontique

d : Faisceau Pyramidal Croisé. e : Faisceau Pyramidal Direct.

f : Décussation motrice. g : Neurones ponto - cérébelleux.

III.....XI : Noyaux moteurs des nerfs crâniens

1

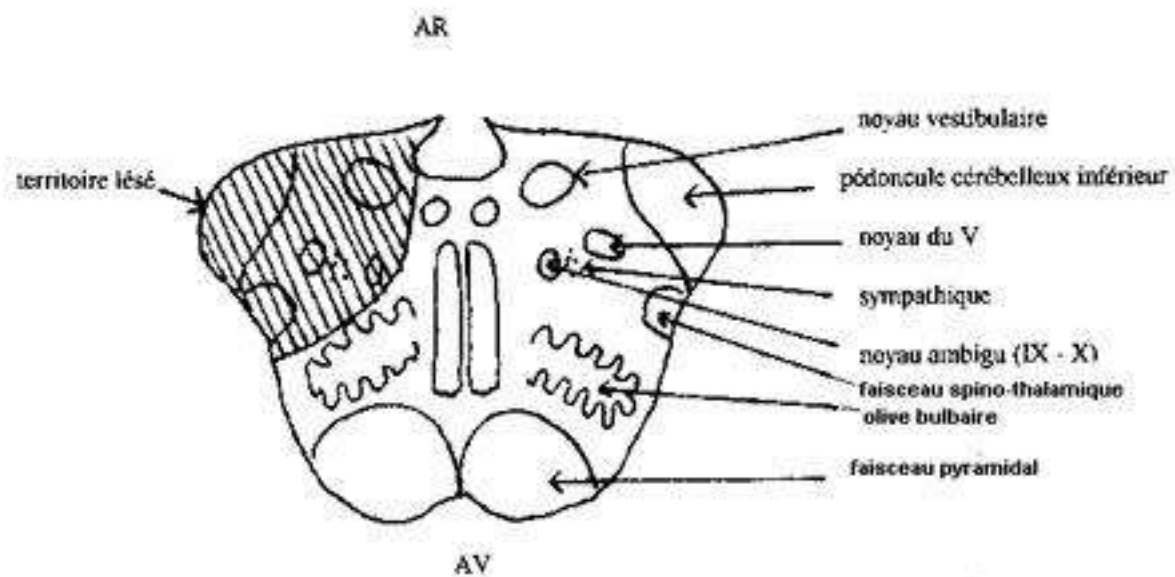
SYNDROMES BULBAIRES

1. SYNDROME ANTÉRIEUR DU BULBE :

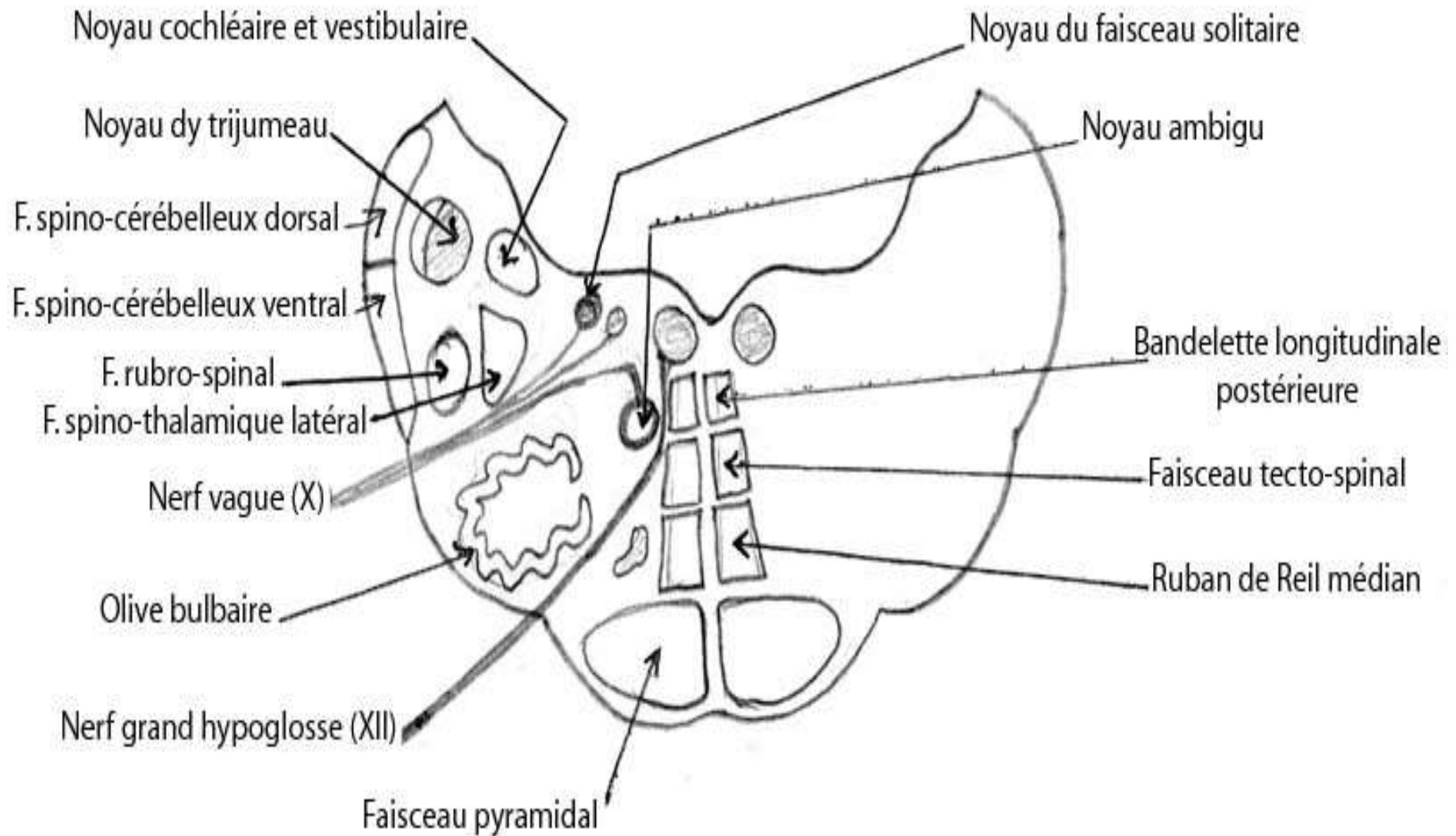
- Il se présente par le syndrome inter-olivaire de Déjerine ou syndrome paramédian de Foix
- Il se caractérise par l'atteinte de :
 - XII homolatéral : amyotrophie de l'hémi-langue homolatéral.
 - Voies pyramidales controlatérales : hémiparésie controlatérale.

2. SYNDROME LATÉRAL DU BULBE (SYNDROME DE WALLENBERG):

- Lié à l'atteinte de l'artère fossette latérale du bulbe.
- Il débute par un vertige puis il se manifeste par:
 - Du côté de la lésion: syndrome cérébelleux, V, VIII, IX, X et CBH.
 - Du côté opposé : atteinte spino-thalamique respectant la face.



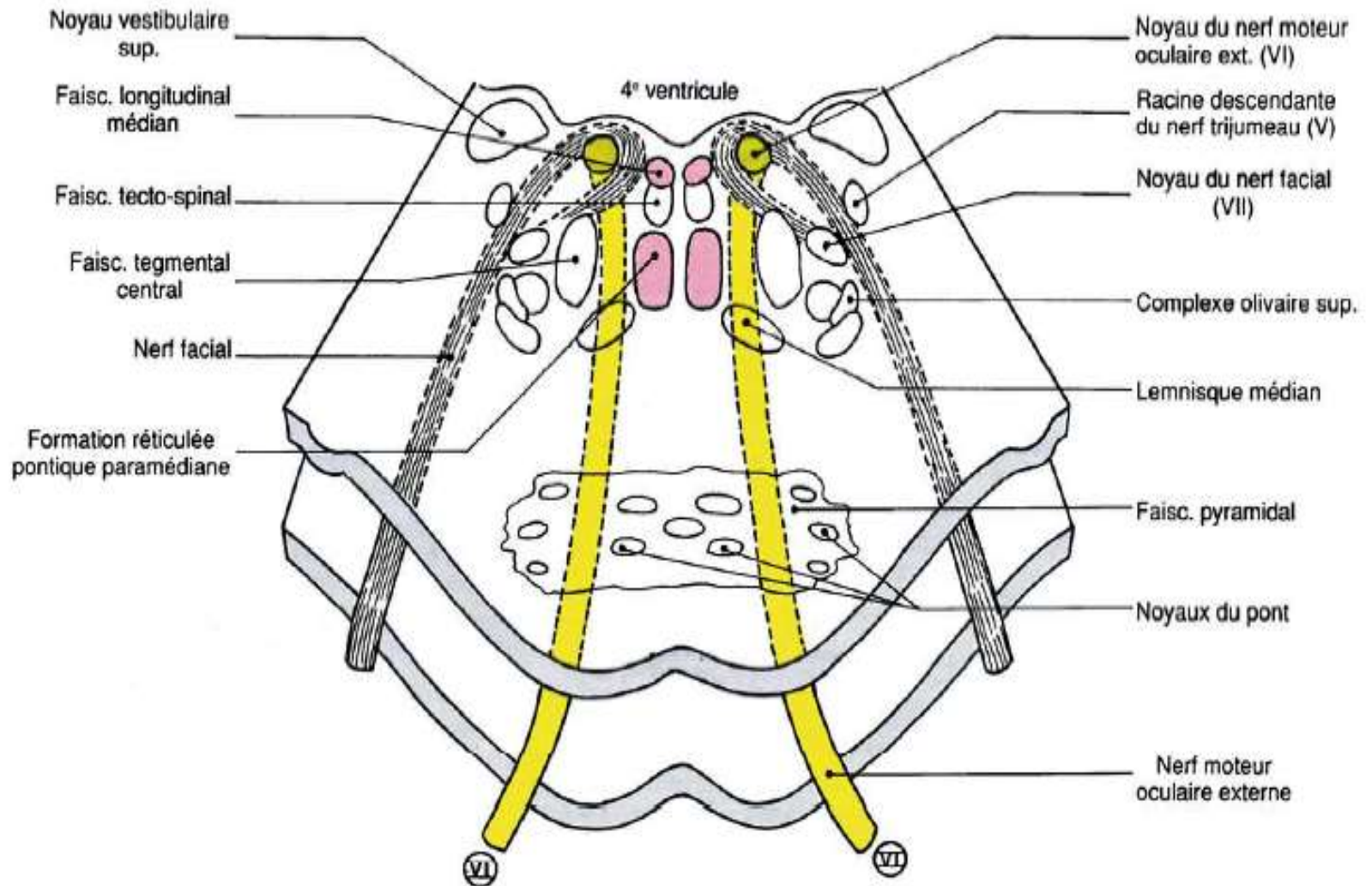
*Coupe horizontale du bulbe
(medulla oblongata)*



Coupe passant par le bulbe ouvert

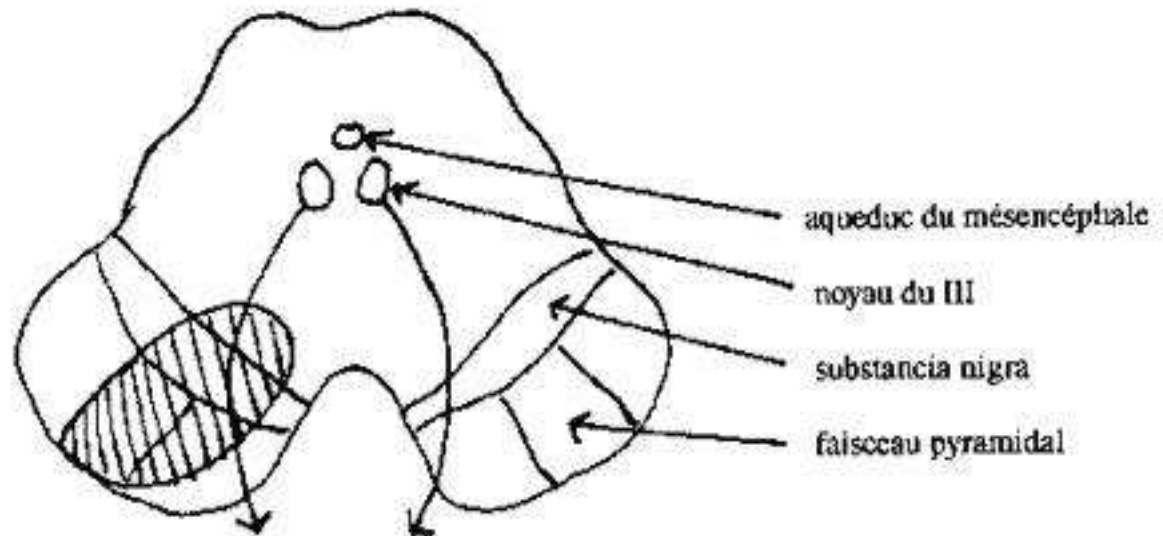
2 SYNDROME PROTUBERANTIEL

- LE SYNDROME DE MILLARD-GUBLER:
- Il comprend :
 - Du côté de la lésion:
 - Atteinte de VII avec une paralysie faciale périphérique.
 - Du côté opposée de la lésion : Une atteinte pyramidale.

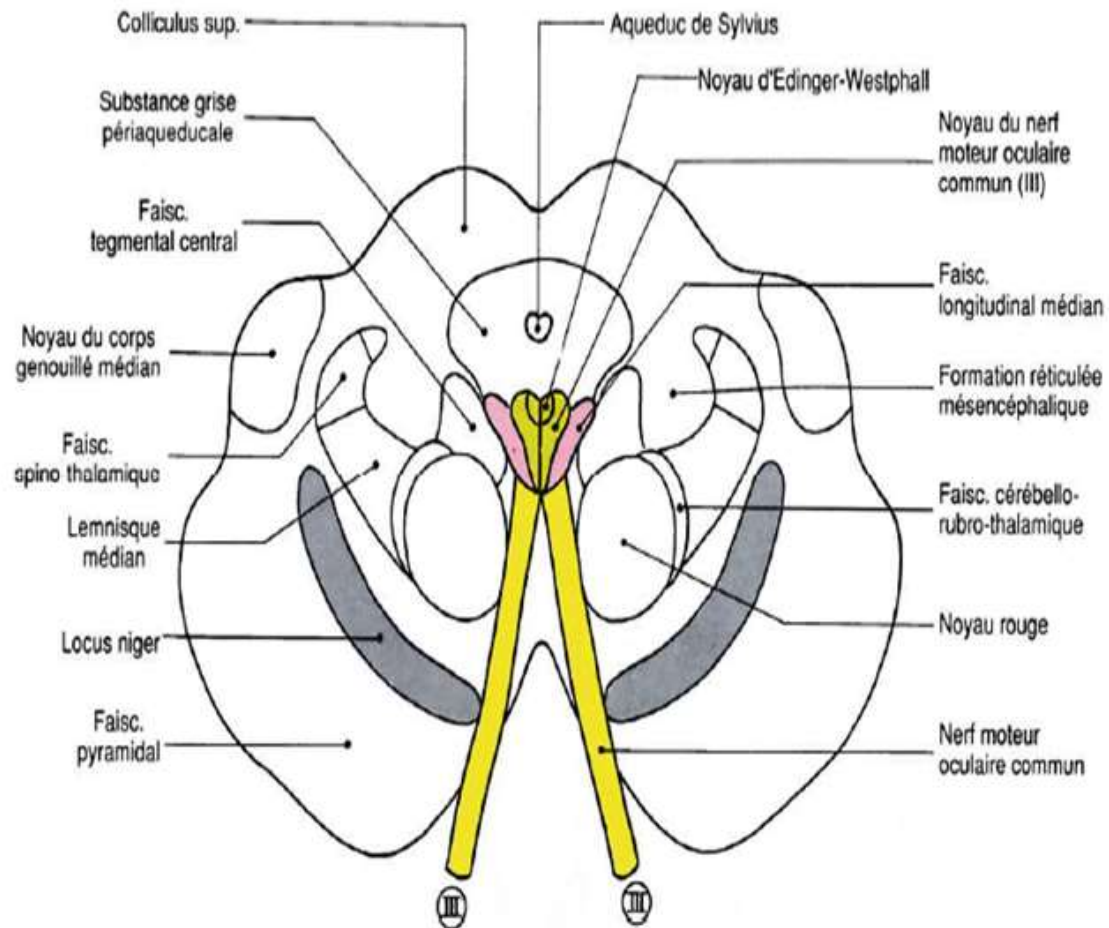


3 SYNDROME PEDONCULAIRE

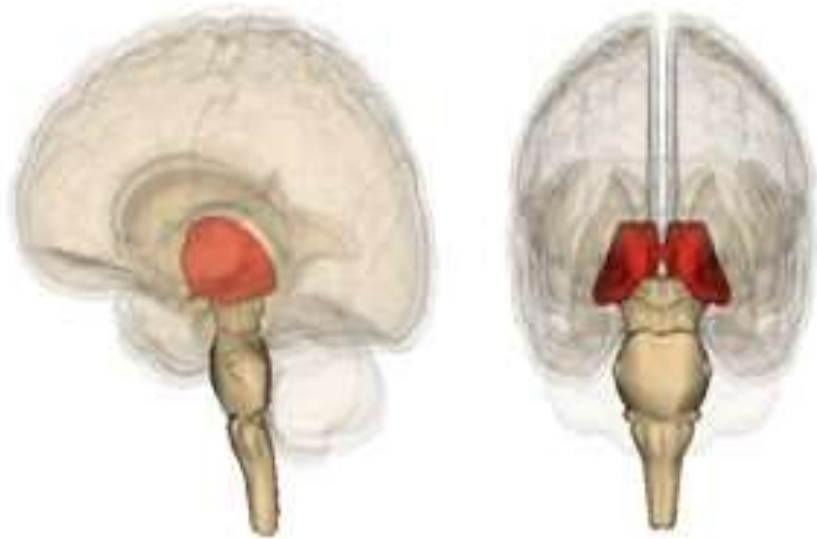
- SYNDROME DE WEBER:
- Il comprend :
 - Du côté de la lésion: atteinte de III.
 - Du côté opposée de la lésion : Une atteinte pyramidale.



Coupe horizontale du mésencéphale



Le SYNDROME THALAMIQUE



- **Le thalamus**
- Principale structure de l'encéphale ,
- Rôle de relai de l'information,
- Composé de nombreux noyaux,

4

SYNDROME THALAMIQUE

- Il est dominé par l'importance des signes sensitifs vu le passage de toutes les voies de la sensibilité par cette structure.

1. SIGNES SENSITIFS:

- Hyperpathie: toute stimulation est pénible et désagréable.
- Hémianesthésie controlatérale à tous les modes.

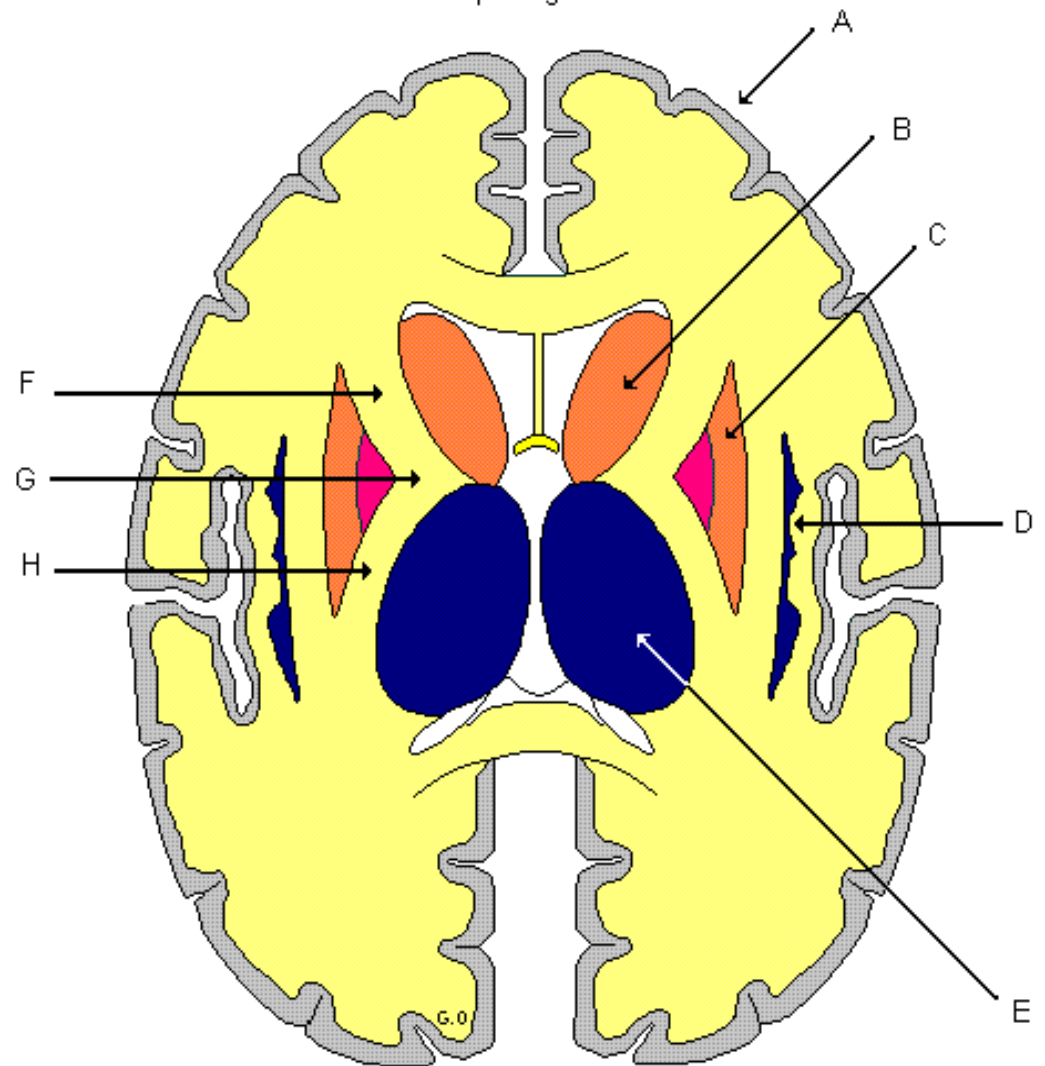
2. SIGNES MOTEURS:

- Hémi-ataxie par l'atteinte des voies de la sensibilité profonde avec une composante cérébelleuse.
- Main thalamique qui se manifeste par des mouvements choréo-athétosique.
- Généralement l'atteinte thalamique **associé** avec une atteinte de la capsule interne qui se représente par une hémiparésie controlatérale.

[S.23]

CERVEAU : COUPE HORIZONTALE

Morphologie interne



A: Cortex. B: Noyau caudé. C: Noyau lenticulaire. D: Claustrum. E: Thalamus.
F: Capsule interne G: Genou de la capsule interne.
H: Bras postérieur de la capsule interne.

5

SYNDROME CAPSULAIRE

- Lié à l'atteinte des voies pyramidales au niveau de la capsule interne.
- Il se manifeste par une hémiparésie proportionnelle pure (pas de trouble phasique ni sensitif).

6 SYNDROMES CORTICAUX (1)

1. PERTE DE FONCTION:

- L'atteinte du cortex de projection se manifeste par perte de fonction motrice (FA), sensitive (PA) et/ou sensorielle (CO).
- L'atteinte du cortex associatif se caractérise par trouble des fonctions neuropsychologiques:
 - Agnosie: trouble d'organisation de la perception.
 - Apraxie: trouble d'organisation du geste.
 - Aphasie: trouble d'organisation du langage dans l'hémisphère gauche.

2. GAIN DE FONCTION:

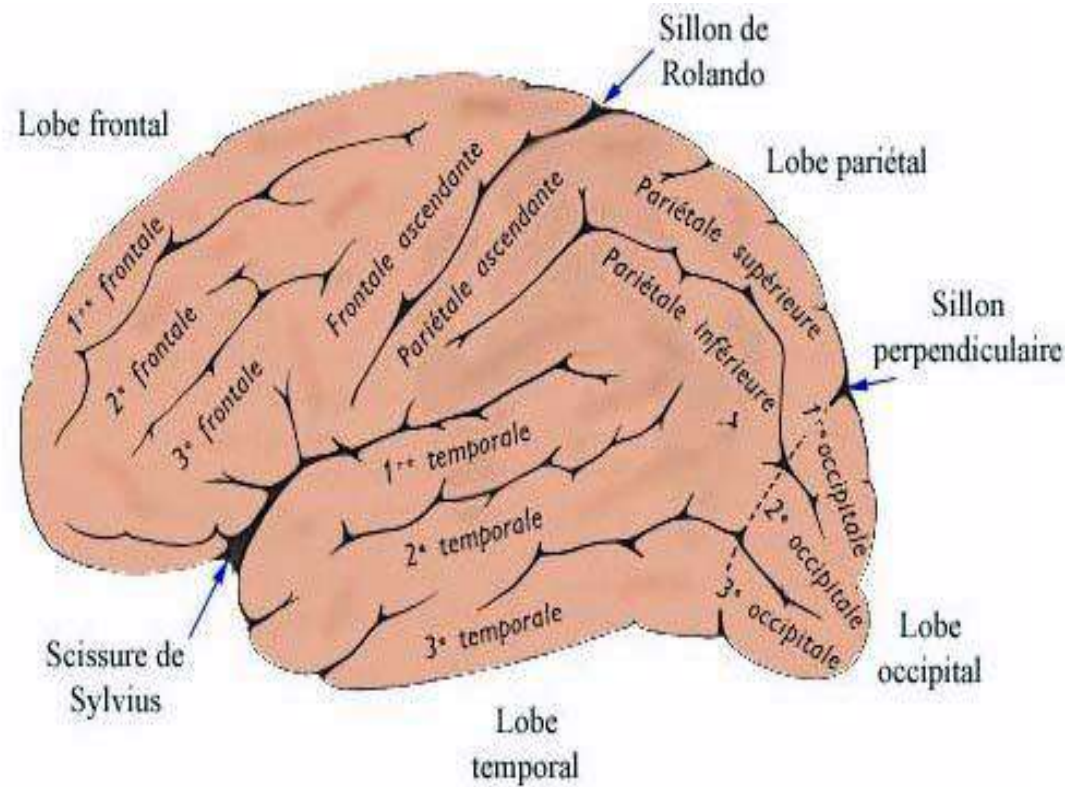
- Hyperactivité du champs électrique qui se représente par des crises d'épilepsie.

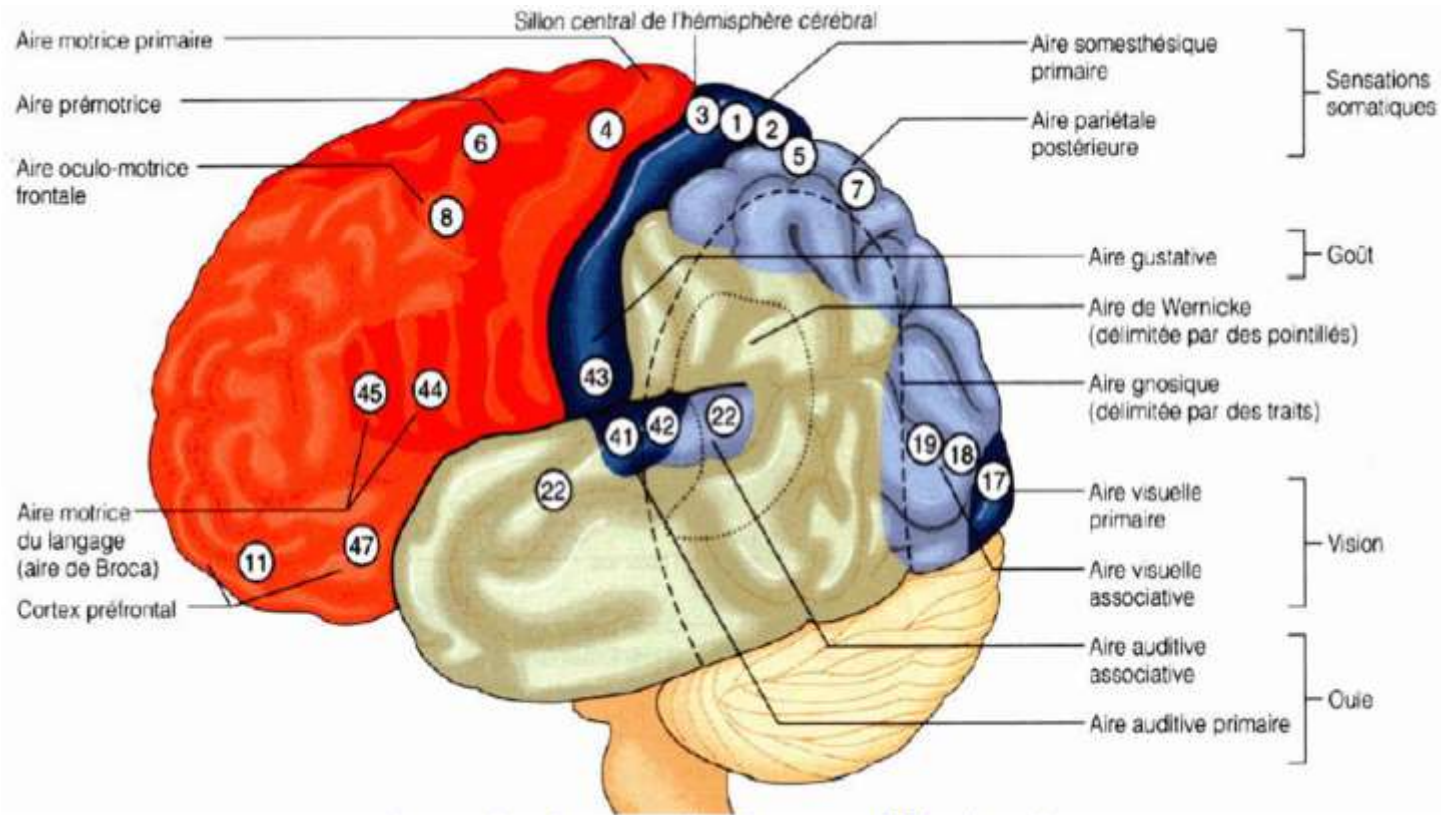
LE SYNDROME FRONTAL

RAPPEL ANATOMIQUE

- Le lobe frontal : la partie du cerveau située en avant de la scissure de Rolando (scissure centrale) et au dessus de la scissure de Sylvius (voir schéma).
- Il représente le tiers de la surface des hémisphères cérébraux.

RAPPEL ANATOMIQUE





RAPPEL ANATOMIQUE

- On divise le lobe frontal en 4 circonvolutions : la FA, F1, F2, F3, et on lui décrit de nombreuses aires, dont on cite surtout :
 - **Aire 4** : aire somato-motrice
 - **Aire 6** : aire pré-motrice
 - **Aire 8** : aire oculomotrice
- Le reste est désigné sous le terme de lobe préfrontal.
- La vascularisation du lobe frontal dépend de l'artère cérébrale antérieure et de la Sylvienne

SEMIOLOGIE

Symptomatologie motrice paroxystique

L'épilepsie motrice partielle (bravais-jacksonienne BJ) se caractérise par des mouvements tonico-cloniques siegent au niveau d'un hémicorps, controlatéraux à la lésion.

- Symptomatologie motrice déficitaire

hémiplégie corticale non proportionnelle à prédominance brachio-faciale ou crurale

SEMIOLOGIE

- **LE SYNDROME PREMOTEUR**

Les lésions de l'aire 6 déterminent des troubles de la motricité complexe, ou perte de la « mélodie cinétique », qui est l'incapacité d'exécuter des actions **séquentielles** (par exemple la séquence paume-poing-côté).

SEMIOLOGIE

- **LE SYNDROME PREMOTEUR**
- Elles peuvent aussi entraîner un« grasping reflexe » ou réflexe de préhension : la stimulation tactile de la paume de la main déclenche une flexion pathologique des doigts.
- une déviation latéralisée du regard(lésion de l'aire 8)
- des troubles du langage (manque du mot, palilalie, mutisme...)

SEMIOLOGIE

- **LE SYNDROME FRONTAL**
- **Personnalité frontale**
- Des changements de type « dépressif » et akinétique, avec apathie et inertie motrice, humeur triste, indifférence affective, réduction de la spontanéité verbale, et impossibilité de programmer l'activité : Lors des lésions de la face latérale ou dorsolatérale.

SEMIOLOGIE

- Lors des lésions de la face orbitaire, on note un comportement puéril, impulsif, désinhibé, mégalomaniacal, appelé *moria frontale*.
- Les patients sont euphoriques, avec tendance aux calembours et aux jeux de mots.
- Cet état d'agitation psychomotrice rend les sujets incapables de mener une activité productive.

SEMIOLOGIE

- Ces troubles peuvent s'accompagner d'une boulimie et d'une hypersexualité.
- **Troubles du comportement moteur**

1– Les persévérations

Elles se définissent comme la répétition anormale d'un comportement spécifique.

SEMIOLOGIE

Les persévérations motrices peuvent apparaître lorsqu'on demande au patient de se laver les mains, de copier un cercle.... Le sujet continuera la même activité, sans être capable de s'arrêter.

SEMIOLOGIE

- *Les comportements d'utilisation et d'imitation*
- Le comportement d'utilisation désigne le fait que lorsqu'on présente au patient des objets au contact de sa main ou dans son champ visuel, il s'en saisit et les utilise.
- Le comportement d'imitation désigne le fait que le patient imite les gestes de l'examineur sans qu'on lui demande.

SEMIOLOGIE

- **Troubles de l'attention**
- une distractibilité qui nécessite de répéter plusieurs fois une consigne pour qu'elle soit exécutée par le patient.

SEMIOLOGIE

- **Troubles cognitifs**

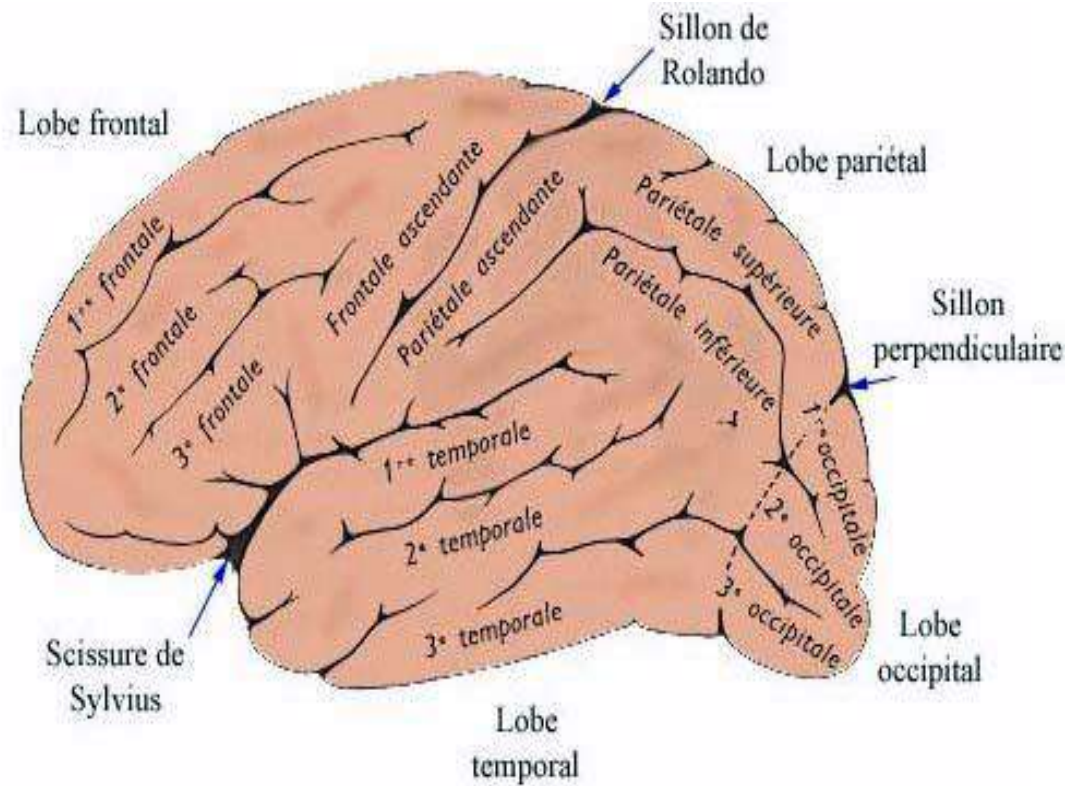
attention, mémoire, langage, perceptions
fonctions exécutives » (jugement, raisonnement
décelables seulement par des tests spécifiques.

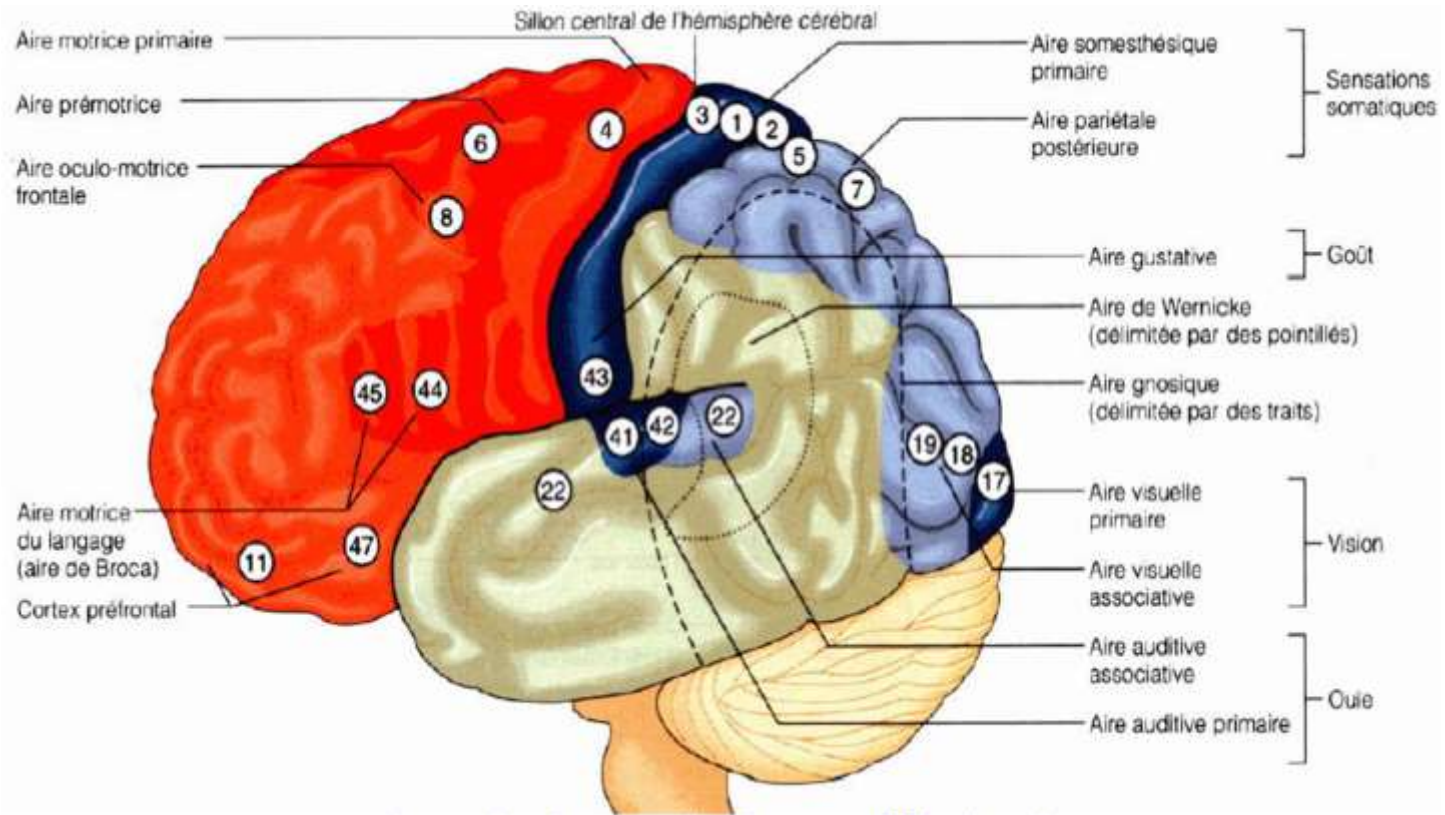
LE SYNDROME TEMPORAL

RAPPEL ANATOMIQUE

- Le lobe temporal, :
- **T1, T2, T3** : sur la face externe de l'hémisphère
- **T4** : sur la face interne de l'hémisphère avec la T5 (circonvolution de l'hippocampe).

RAPPEL ANATOMIQUE





RAPPEL ANATOMIQUE

- Sur le plan fonctionnel on le divise en 2 zones :
- **Néocortex temporal (T1 à T4) : avec le gyrus de Heschl (aire 41 et 42 de Brodmann), terminaison des voies acoustiques et le carrefour temporo-pariéto-occipital (langage, praxie, gnosie)**
- **Système limbique (T5, noyau amygdalien, corne d'Ammon) : comportements instinctifs.**
- La vascularisation est assurée par l'artère temporale Antérieure, Postérieure et l'artère du pli courbe.

Sémiologie

- **Troubles sensoriels et agnosies :**
- **Troubles auditifs :**
- **Surdit  corticale :** trouble de la perception auditive des messages sensoriels sans alt ration de l'oreille .
- **Agnosies auditives :** agnosie des bruits, agnosie musicale, agnosie pour les mots (incompr hension du langage parl )

Sémiologie

- **Troubles olfactifs** : hypo- ou anosmie
- **Troubles gustatifs** : exceptionnels, agueusie
- **Hémianopsie Latérale Homonyme en quadrant** : atteinte des radiations optiques .
- **Signes vestibulaires** : troubles de l'équilibre et vertiges
- **Aphasie** : est un signe majeur : aphasie de Wernicke
- **Hallucinations** : auditives, olfactives, gustatives, visuelles

Sémiologie

- **Epilepsie temporale** : il s'agit de crises d'épilepsie complexes et variées :
- **Crise uncinée** : (lésion de l'uncus de l'hippocampe).
sentiment d'étrangeté avec des phénomènes hallucinatoires : goût étrange, odeurs désagréables, vision de scènes animées et colorées .Etat de rêve, phénomène de pensée forcée.

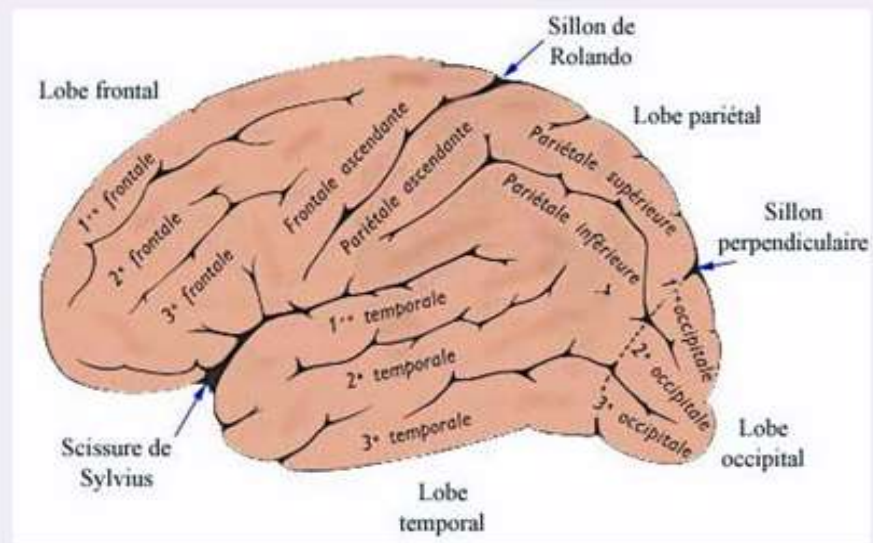
Sémiologie

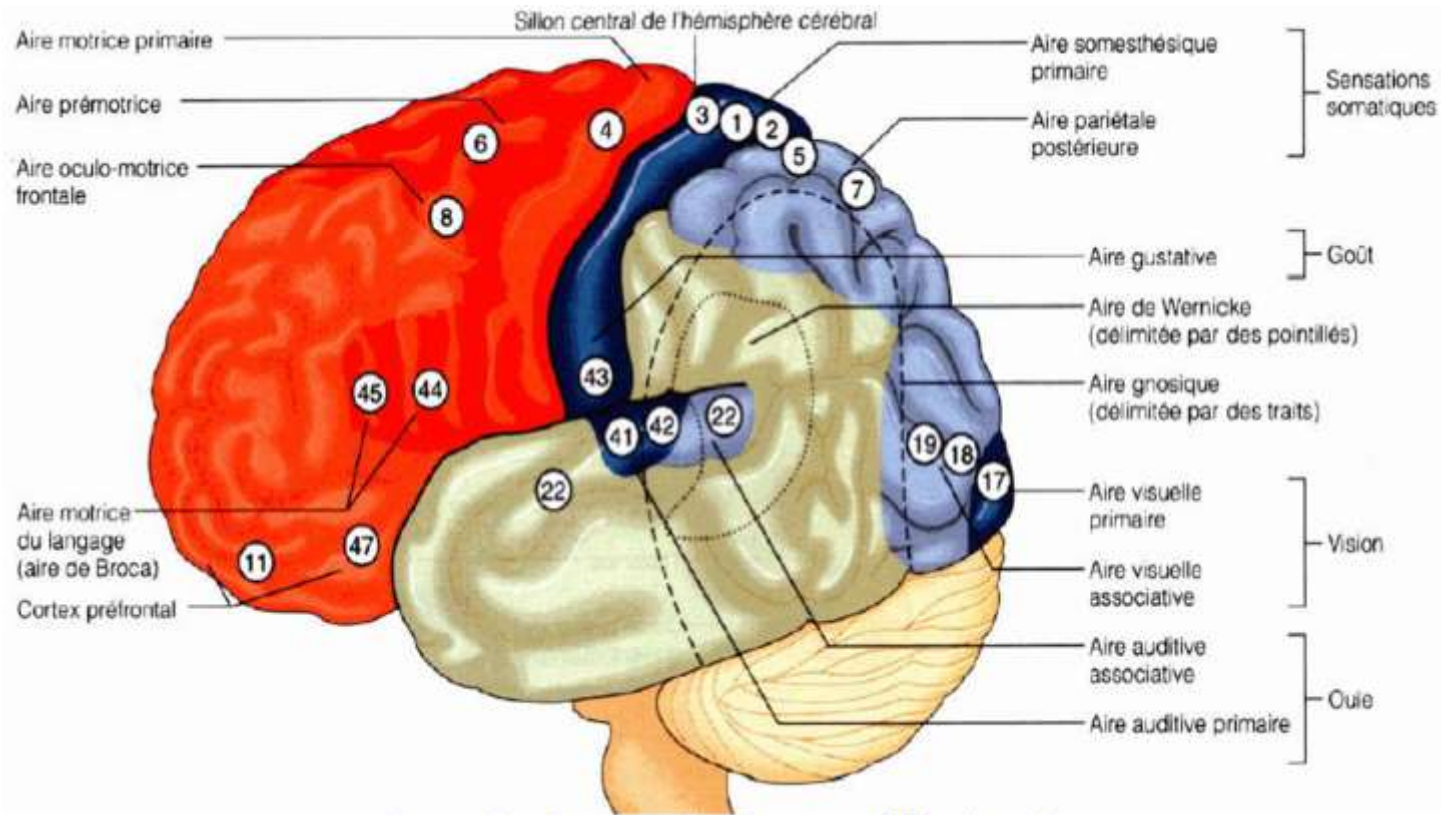
- **Crise viscéro-végétative** : abdominale (coliques), respiratoire (polypnée)
- **Crises motrices** (masticatrices, automatismes buconasaux (mâchonnement, déglutition)), crises aversives (crise giratoire),
- **Crises affectant le langage** : vocalisation, palilalie

LE SYNDROME PARIETAL

- **RAPPEL ANATOMIQUE**

- Le lobe pariétal est situé à la partie supérieure et moyenne de l'hémisphère cérébral, limité en avant par la scissure de Rolando qui le sépare du lobe frontal ; et en bas par la scissure de Sylvius qui le sépare du lobe temporal, en arrière par la scissure perpendiculaire interne qui le sépare du lobe occipital.





RAPPEL ANATOMIQUE

- On lui reconnaît 3 circonvolutions : PA, P1, P2, et trois zones
- **Aire 1, 2,3 de Brodmann : cortex somato-sensitif (aire réceptrice ou de projection primaire)**
- **Aire 5,7 de Brodmann : aire somato-psychique de Tilney et Riley**
- **Aire 40 et 39 : correspond à l'aire tactognosique de Lhermitte.**
- La vascularisation du lobe pariétal dépend de l'artère cérébrale antérieure et de la Sylvienne

Sémiologie

A-Troubles sensitifs

- **Subjectifs** : paresthésies (aire somato-sensitive), rarement à type de douleurs
- **Objectifs** :
- **Agnosies tactiles** :
- **Syndrome de Déjerine et Mouzon** : hémianesthésie controlatérale (à tous les modes)
- **Syndrome de Verger-Déjerine** : perte du sens de reconnaissance par le toucher les formes, consistance, poids, température...des objets

Sémiologie

- **B-Troubles sensoriels :**
- **Troubles vestibulaires :** sensations vertigineuses
- **Troubles du goût :** hallucinations gustatives (amertume, acidité ...)
- **Troubles visuels :** quadranopsie inférieure controlatérale, Hémianopsie Latérale Homonyme.

Sémiologie

C-Troubles du schéma corporel :

- **Lésion de l'hémisphère mineur** : troubles controlatéraux
Hémi-asomatognosie : méconnaissance de l'hémi-corps
- **Anosognosie** : méconnaissance du trouble présenté
- **Lésion de l'hémisphère dominant** :
- **Auto-topoagnosie** : impossibilité de localiser les différentes parties de son corps
- **Agnosie digitale** : incapacité d'identifier ses doigts ou celles de l'examineur
- Indistinction droite gauche

Sémiologie

D-Troubles praxiques :

- **Apraxie idéatoire** : impossibilité de réaliser un mouvement composé d'un ensemble de sous mouvements élémentaires organisés.
- **Apraxie idéomotrice** : incapacité d'exécuter un geste simple sur demande
- **Apraxie constructive** : difficulté de définir la relation des objets entre eux
- **Apraxie de l'habillement**

Sémiologie

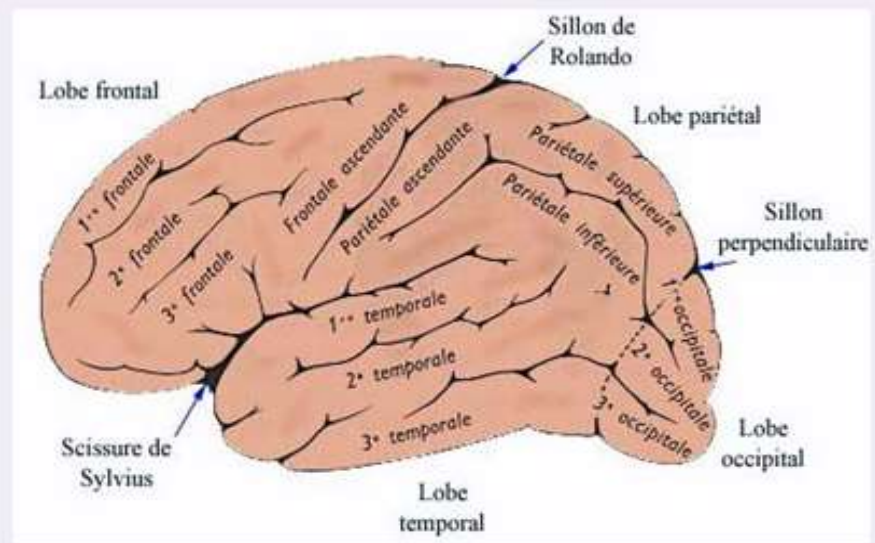
E-Troubles du langage :

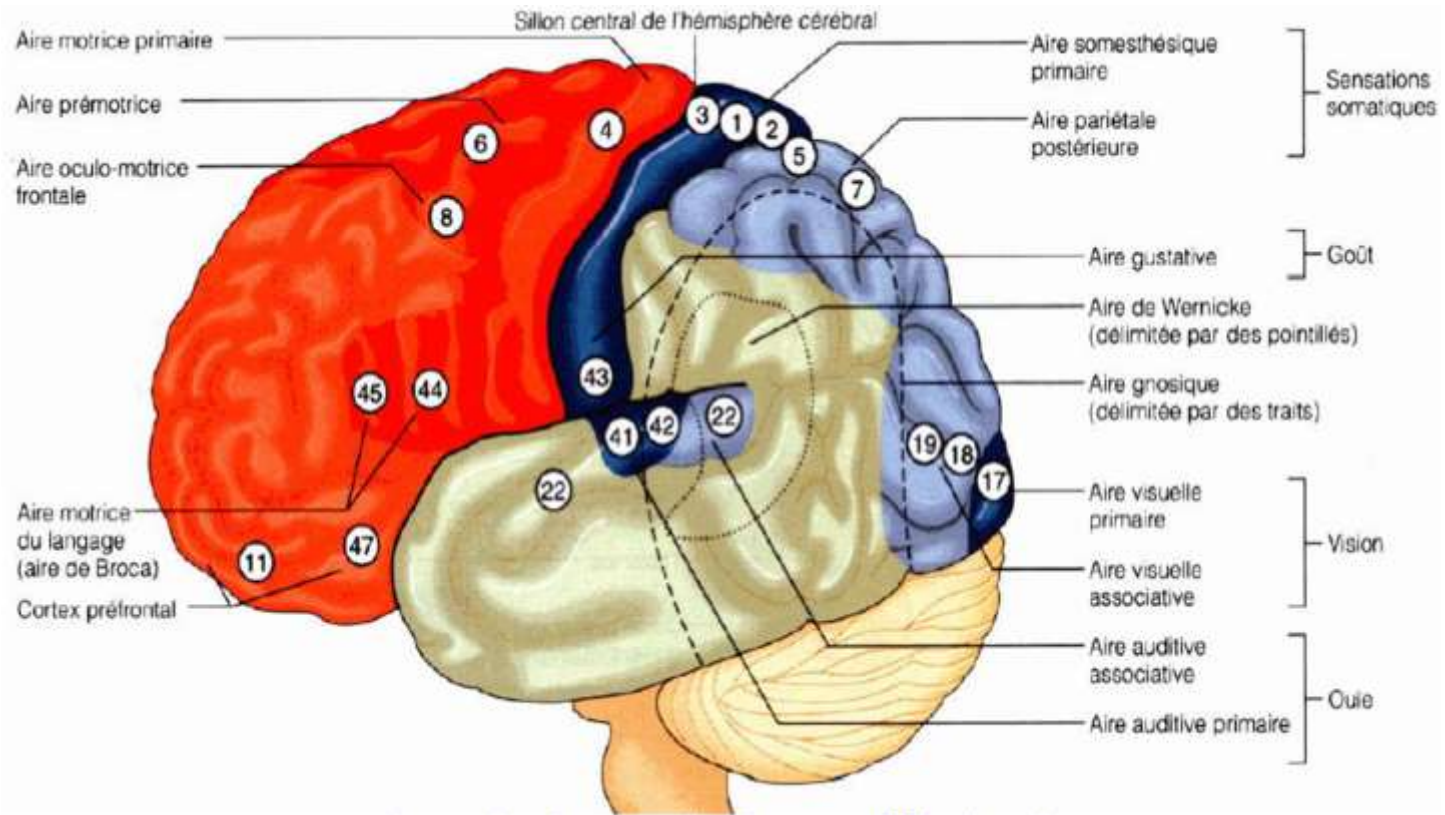
- **Aphasie de Wernicke :**
- **Agraphie :** trouble de l'écriture spontanée, copiée ou dictée.
- **Alexie :** trouble de la lecture
- **F-Crises d'épilepsie :** partielles, sensitives

Syndrome occipital

Rappel anatomique

- Le lobe occipital, véritable centre de la vision constitue le pôle postérieur de l'hémisphère cérébral, présente 3 faces : interne, externe, inférieure ; ses limites avec le lobe temporal sont virtuelles, il est séparé du lobe pariétal par la scissure perpendiculaire interne.





Rappel anatomique

- Il présente 6 circonvolutions : O1, O2, O3, O4, O5, O6.
- Sur le plan fonctionnel, on distingue :
- **Aire striée** : aire 17 de Brodmann ou aire sensorio-visuelle
- **Aire parastriée** (aire 18 de Brodmann) et peristriée (aire 19 de Brodmann) : aire visuo-psychique (reconnaissance des objets).
- Le lobe occipital est vascularisé par l'artère calcarine (branche de la cérébrale postérieure) ainsi que la temporale postérieure (branche de la sylvienne)

Sémiologie

- Centrée sur la fonction visuelle.
- **Hémianopsies (atteinte de l'aire 17) :**
- **Hémianopsie Latérale Homonyme** (perte de la vision dans un hémichamps), hémianopsie en quadrant (moitié inférieure ou supérieure de l'hémichamps visuel)
- **Scotomes hémianopiques**, hémianopsie double (atteinte de la vision périphérique et conservation de la vision maculaire)

Sémiologie

- **Cécité corticale** (atteinte bilatérale de l'aire 17) : perte de vision totale, mais les réflexes pupillaires sont conservés et le fond d'oeil est normal
- **Hallucinations visuelles** et métamorphopsies (aire para et peristriée) : hallucinations élémentaires ou complexes, métamorphopsies (perception modifiée de l'objet)

Sémiologie

- **Agnosies visuelles** (aire para et peristriée) : trouble de la reconnaissance des objets, des personnes ou des symboles graphiques par la vue : agnosie des objets (cécité psychique) ; agnosie des couleurs ; agnosie des symboles graphiques, agnosie spatiale
- **Troubles oculomoteurs** (aires 18 et 19) : abolition des mouvements oculaires de poursuite

Sémiologie

- **Troubles psychiques** : amnésie de fixation
- **Crises d'épilepsie** : à symptomatologie visuelle.

